

Buku Ajar

PROMOSI KESEHATAN

Nur Fadhilah Umi Aniroh Syahrul
Dewi Yuliana Heri Tri Wibowo



BUKU AJAR: PROMOSI KESEHATAN

Penulis:

Nur Fadhillah, M.Kes., Ph.D.

Ns.Umi Aniroh,S.Kep.,M.Kes.

Syahrul, SKM., M.Kes.

Dewi Yuliana,S.Kep., Ns., M.Kep.

Heri Tri Wibowo, SKM., SKep.Ns., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar: Promosi Kesehatan

Penulis: Nur Fadhilah, M.Kes., Ph.D.

Ns.Umi Aniroh,S.Kep.,M.Kes.

Syahrul, SKM., M.Kes.

Dewi Yuliana,S.Kep., Ns., M.Kep.

Heri Tri Wibowo, SKM., SKep.Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syauckani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-29-6

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar yang berjudul "Promosi Kesehatan: Strategi, Konsep, dan Aplikasi dalam Keperawatan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan praktisi dan akademisi keperawatan yang terus berkembang seiring meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Promosi kesehatan merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan terencana. Untuk itu, buku ini secara komprehensif membahas lima strategi pendekatan utama dalam promosi kesehatan yang meliputi pendekatan edukasi, advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan lintas sektor, dan pengembangan kebijakan publik.

Selain menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan secara detail, buku ini juga memberikan panduan perencanaan promosi kesehatan agar pelaksanaannya di lapangan efektif dan efisien. Untuk memperkaya pembahasan, aplikasi nyata promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok turut disertakan, sehingga mahasiswa maupun tenaga kesehatan dapat mengaplikasikan teori ke dalam praktik klinis dengan mudah.

Tidak kalah penting, pembahasan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya perubahan perilaku sehat yang berkelanjutan, baik secara individual maupun kolektif. Materi ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi penting dalam mendorong peningkatan kesehatan secara keseluruhan di komunitas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat besar bagi perkembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam bidang promosi kesehatan.

Juni, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 LIMA STRATEGI PENDEKATAN PROMOSI KESEHATAN..... 1

A. Building Healthy Public Policy (Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan).....	3
B. <i>Creating Supportive Environments</i> (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung).....	5
C. Strengthening Community Action (Menguatkan Aksi Masyarakat).....	6
D. <i>Developing Personal Skills</i> (Mengembangkan Keterampilan Individu)	8
E. <i>Reorienting Health Services</i> (Reorientasi layanan kesehatan).....	9
F. Latihan	11
G. Kunci Jawaban	16
H. Rangkuman Materi	16
I. Glosarium	18
J. Daftar Pustaka	19

BAB 2 KONSEP DASAR PROMOSI KESEHATAN.....21

A. Definisi Promosi Kesehatan	22
B. Prinsip-Prinsip Promosi Kesehatan	22
C. Strategi Promosi Kesehatan.....	23
D. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan.....	25
E. Pendekatan dalam Promosi Kesehatan.....	26
F. Tantangan dalam Promosi Kesehatan.....	27
G. Latihan Soal	28
H. Rangkuman Materi	30
I. Glosarium	32
J. Daftar Pustaka	33

BAB 3 PERENCANAAN PROMOSI KESEHATAN35

A. Konsep Dasar Promosi Kesehatan.....	37
B. Teori dan Model Promosi Kesehatan.....	38
C. Perencanaan Promosi Kesehatan	40
D. Pelaksanaan Promosi Kesehatan	42
E. Evaluasi Program Promosi Kesehatan	45
F. Studi Kasus dan Aplikasi di Lapangan.....	47
G. Penutup dan Rekomendasi.....	48
H. Latihan Soal	49

I. Rangkuman Materi	51
J. Glosarium	53
K. Daftar Pustaka	54

BAB 4 APLIKASI PROMOSI KESEHATAN DALAM ASUHAN

KEPERAWATAN PADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK	57
A. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Individu	59
B. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Keluarga	60
C. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Kelompok.....	62
D. Latihan Soal	64
E. Rangkuman Materi	65
F. Glosarium	66
G. Daftar pustaka	68

BAB 5 PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

A. Definisi PHBS.....	74
B. Tujuan PHBS.....	75
C. Indikator PHBS	75
D. Manfaat PHBS.....	77
E. Sasaran PHBS menurut tatanannya	79
F. Faktor yang mempengaruhi PHBS.....	82
G. Pengelolaan PHBS.....	83
H. Peran Perawat dalam PHBS.....	89
I. Latihan	91
J. Rangkuman Materi.....	92
K. Glosarium	92
L. Daftar Pustaka	93

PROFIL PENULIS

BAB 1

LIMA STRATEGI PENDEKATAN PROMOSI KESEHATAN

Pendahuluan:

Promosi kesehatan merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah berbagai penyakit. Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup perubahan sosial, kebijakan, serta pemberdayaan individu dan komunitas untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih sehat. Pendekatan promosi kesehatan menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tantangan kesehatan global, seperti penyakit tidak menular, perubahan gaya hidup, dan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan.

Pendekatan dalam promosi kesehatan didasarkan pada prinsip bahwa kesehatan bukan sekadar hasil dari perawatan medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lima pendekatan utama dalam promosi kesehatan, sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Ottawa tahun 1986, meliputi: (1) kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, (2) penciptaan lingkungan yang mendukung, (3) penguatan aksi komunitas, (4) pengembangan keterampilan individu, dan (5) reorientasi layanan kesehatan. Kelima pendekatan ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya dalam menjaga kesehatannya.

Kebijakan publik yang mendukung kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi, kebijakan, dan legislasi yang dibuat oleh pemerintah dapat melindungi serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Penciptaan lingkungan yang mendukung berfokus pada perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi agar kondusif bagi kesehatan. Penguatan aksi komunitas menekankan pada peran aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Sementara itu, pengembangan keterampilan individu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka secara mandiri. Terakhir, reorientasi layanan kesehatan menekankan perubahan sistem layanan kesehatan agar lebih berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan, bukan hanya pada pengobatan penyakit.

Melalui pemahaman dan penerapan lima pendekatan ini, diharapkan kesehatan masyarakat dapat meningkat secara holistik dan berkelanjutan. Kajian ini akan

membahas setiap pendekatan secara mendalam, termasuk konsep dasar, implementasi di berbagai sektor, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, promosi kesehatan dapat menjadi landasan bagi pembangunan kesehatan yang lebih inklusif dan efektif dalam menjawab tantangan kesehatan di masa kini dan masa depan.

Tujuan Intruksional:

Setelah mempelajari materi ini, pembelajar dapat memahami dan menjelaskan kembali lima strategi pendekatan promosi kesehatan.

Capaian Pembelajaran:

Memahami dan dapat menjelaskan kembali:

- *Building Healthy Public Policy* (Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan)
- *Creating Supportive Environments* (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung)
- *Strengthening Community Action* (Menguatkan Aksi Masyarakat)
- *Developing Personal Skills* (Mengembangkan Keterampilan Individu)
- *Reorienting Health Services* (Reorientasi layanan kesehatan)

Uraian Materi

A. Building Healthy Public Policy (Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan)

Building Healthy Public Policy (Kebijakan Publik yang Mendukung Kesehatan) merupakan salah satu dari lima pilar utama strategi promosi kesehatan yang diperkenalkan dalam *Ottawa Charter for Health Promotion* pada tahun 1986, adalah sebuah pendekatan dalam promosi kesehatan yang menitikberatkan pada pembuatan keputusan politik dan administratif yang secara eksplisit mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat (WHO, 2012). Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi pertimbangan kesehatan ke dalam proses pembuatan kebijakan di berbagai sektor, tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan semacam ini mempermudah atau memungkinkan pilihan yang sehat bagi warga negara dengan meningkatkan kondisi sosial dan fisik yang mendukung kesehatan (MacDougall & Leeuw, 2007).

Kebijakan publik yang mendukung kesehatan adalah serangkaian keputusan politik dan administratif yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk hidup sehat (Leppo et al, 2013). Hal ini mencakup berbagai sektor, termasuk diantaranya adalah transportasi, pendidikan, perumahan, industri, pelayanan dan fasilitas public, dan lingkungan, yang semuanya dapat mempengaruhi determinan sosial kesehatan. Dengan mengintegrasikan pertimbangan kesehatan ke dalam kebijakan publik, pemerintah secara tidak langsung telah melakukan upaya untuk mengurangi faktor risiko, dan meningkatkan faktor pendukung yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan publik yang mendukung kesehatan meliputi: 1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan mengintegrasikan pertimbangan kesehatan ke dalam semua sektor kebijakan, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sehat dan produktif, 2) Mengurangi Ketidaksetaraan Kesehatan: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas kesehatan antar kelompok sosial dengan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan Kesehatan, dan 3) Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Kesehatan: Melalui regulasi dan inisiatif yang mempromosikan lingkungan fisik dan sosial yang kondusif bagi perilaku sehat (Malem, 2022).

Apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berorientasi pada sektor kesehatan, maka hal ini akan memberikan dampak positif dan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat, tidak hanya bidang kesehatan tetapi juga dapat

mengurangi beban ekonomi. Beberapa manfaat dari implementasi kebijakan publik yang mendukung kesehatan diantaranya adalah; 1) Peningkatan Efektivitas Program Kesehatan: Kebijakan publik yang mendukung kesehatan memastikan bahwa program dan intervensi kesehatan lebih terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) Penguatan Pemberdayaan Masyarakat: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isu-isu kesehatan., dan 3) Pengurangan Beban Ekonomi: Kebijakan yang proaktif dalam pencegahan penyakit dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang dan meningkatkan produktivitas (Green et al, 2005).

Kebijakan public yang mendukung Kesehatan berfokus pada pengembangan regulasi dan kebijakan yang memastikan Masyarakat memiliki Kses terhadap layanan dan lingkungan yang mendukung Kesehatan. Contohnya larangan merokok di tempat umum, kebijakan pajak terhadap minuman bersoda, dan peraturan tentang keamanan pangan. Implementasi kebijakan ini memerlukan Kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung gaya hidup sehat.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah salah satu contoh implementasi kebijakan publik yang mendukung Kesehatan, program ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan dan melibatkan berbagai sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Selain itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, merupakan upaya lintas sektor untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat.

Mengawal tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan sebuah kebijakan publik yang mendukung Kesehatan, yaitu "Program skrining kesehatan gratis" (Kemenkes RI, 2024). Program ini menawarkan skrining kesehatan tahunan gratis bagi semua warga negara pada hari ulang tahun mereka. Layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan tekanan darah, penilaian risiko penyakit jantung atau stroke, serta tes mata. Program ini awalnya menargetkan anak-anak di bawah enam tahun dan orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, dengan tujuan mendorong deteksi dini dan pencegahan penyakit serius seperti stroke, penyakit jantung, dan tuberculosis (TBC).

Implementasi kebijakan publik yang mendukung kesehatan telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan akses mudah dan gratis ke layanan skrining kesehatan, pemerintah dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, yang pada gilirannya memungkinkan

intervensi lebih awal dan pengelolaan penyakit yang lebih efektif. Selain itu, kebijakan semacam ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan perawatan kesehatan proaktif, mengurangi beban penyakit kronis, dan menurunkan angka kematian dini ***Creating Supportive Environments* (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung)**

Masyarakat Indonesia sangat beragam dan kompleks, saling terkait satu dengan yang lain, ada interaksi dan interelasi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya dan lain lain. Hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dan lingkungannya merupakan dasar dari pendekatan sosioekologi terhadap kesehatan (Green, 2005). Prinsip panduan secara keseluruhan untuk dunia, negara, wilayah dan komunitas, adalah kebutuhan untuk mendorong pemeliharaan timbal balik, menjaga satu sama lain, antara komunitas dengan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nutbeam, D., & Harris, E, 2010).

Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan utama dalam promosi kesehatan adalah "*Creating Supportive Environments*" atau menciptakan lingkungan yang mendukung. Menurut Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986), "*Creating Supportive Environments*" adalah pendekatan dalam promosi kesehatan yang berfokus pada penciptaan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung individu dalam menjalankan perilaku sehat. Lingkungan yang mendukung mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan publik, desain infrastruktur, dan intervensi sosial yang mempermudah individu dalam mengadopsi gaya hidup sehat.

Strategi "*Creating Supportive Environments*" sangat relevan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, upaya kesehatan menjadi lebih efektif karena individu lebih mudah menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kota Ramah Pejalan Kaki dan Pesepeda, adalah salah satu bentuk implementasi startegi ini, beberapa kota besar telah menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan aktivitas fisik masyarakat. Kemudian diselenggarakannya sekolah sehat, yaitu sekolah yang menyediakan kantin sehat dan lingkungan bersih mendukung kebiasaan makan sehat serta mencegah penyakit menular. Termasuk adanya kebijakan bebas rokok di tempat umum, dimana kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi paparan asap rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan di buatnya

Taman Kota dan Ruang Hijau di perkotaan dengan meningkatkan kesehatan mental dan fisik masyarakat.

Dengan demikian, jelas bahwa ada banyak manfaat yang dapat dirasakan sehubungan dengan strategi *Creating Supportive Environment*, diantaranya; 1) Meningkatkan kualitas hidup; artinya dengan lingkungan yang sehat, individu memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, makanan sehat, dan udara bersih, 2) Mencegah penyakit; dengan lingkungan yang bersih dan aman dapat mengurangi risiko penyakit menular dan tidak menular, 3) Mendorong perilaku sehat; Dengan adanya fasilitas pendukung, seperti jalur sepeda dan taman, masyarakat lebih terdorong untuk beraktivitas fisik, dan 4) Meningkatkan produktivitas; secara otomatis bahwa lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dapat meningkatkan kinerja serta mengurangi angka absensi akibat penyakit.

Creating Supportive Environments merupakan salah satu strategi penting dalam promosi kesehatan yang bertujuan menciptakan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang mendukung perilaku sehat. Implementasi konsep ini dalam pembangunan kesehatan sangat relevan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, baik melalui kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, maupun edukasi masyarakat mengenai pentingnya lingkungan sehat.

C. Strengthening Community Action (Memperkuat Aksi Masyarakat)

Promosi kesehatan merupakan bagian integral dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi utama dalam promosi kesehatan adalah *Strengthening Community Action* atau penguatan aksi masyarakat. Konsep ini menitikberatkan pada pemberdayaan komunitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Penerapan aksi komunitas yang kuat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Strengthening Community Action merupakan salah satu prinsip utama dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas agar lebih aktif dalam menentukan kebijakan serta tindakan yang berhubungan dengan kesehatan mereka. Konsep ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Prinsip Utama *Strengthening Community Action* yaitu; **1) Pemberdayaan Masyarakat**; Memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar komunitas dapat mengambil tindakan dalam meningkatkan kesehatan mereka, **2) Partisipasi Aktif**; Melibatkan masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program Kesehatan, 3) **Kemitraan dengan Berbagai Sektor**; Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, dan komunitas untuk menciptakan kebijakan dan program kesehatan yang berkelanjutan, 4) **Akses terhadap Sumber Daya Kesehatan**; Memastikan bahwa komunitas memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan kesehatan, dan dukungan sosial.

Strengthening Community Action memiliki relevansi yang kuat dalam pembangunan kesehatan karena mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ketiga (Good Health and Well-being), mendorong desentralisasi kebijakan kesehatan, yang memungkinkan pendekatan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan lokal, dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi tantangan kesehatan seperti penyakit menular dan tidak menular.

Green dan Kreuter (2005) dalam bukunya *Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach*, penguatan aksi masyarakat melibatkan mobilisasi sumber daya lokal, pembentukan jaringan sosial, serta pengembangan kebijakan berbasis komunitas. Tujuan utama dari *Strengthening Community Action* adalah: 1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya Kesehatan, 2) Memperkuat kepemimpinan komunitas dalam merancang program Kesehatan, 3) Meningkatkan kesadaran kolektif terhadap isu Kesehatan, dan 4) Mengembangkan solusi berbasis komunitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Program posyandu merupakan contoh nyata dari pemberdayaan masyarakat dalam promosi Kesehatan, melalui kader-kader kesehatan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pemantauan gizi. *Program Community-Based Total Sanitation* (STBM) yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui lima pilar utama, termasuk stop buang air besar sembarangan dan pengelolaan air minum yang aman. Selanjutnya program Kampung Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Program ini melibatkan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, seperti aktivitas fisik, konsumsi makanan bergizi, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Kemenkes RI, 2018).

Strengthening Community Action merupakan pendekatan penting dalam promosi kesehatan yang menekankan peran aktif komunitas dalam mengembangkan kebijakan dan program kesehatan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, efektivitas program kesehatan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar strategi ini berjalan dengan optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor

swasta, untuk menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi komunitas.

D. *Developing Personal Skills* (Mengembangkan Keterampilan Individu)

Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat, yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok tersebut terwujud. Oleh sebab itu, strategi untuk mewujudkan keterampilan individu-individu (*personnel skill*) dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah sangat penting. Langkah awal dari peningkatan keterampilan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka ini adalah memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan profesional, meningkatkan kesehatan, dan sebagainya. Metode dan teknik pemberian pemahaman ini lebih bersifat individual daripada massa.

Mengembangkan keterampilan individu, atau *developing personal skills*, adalah salah satu strategi utama dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Strategi ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka.

Indonesia merumuskan pengertian promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Depkes RI, 2005). Berangkat dari rumusan tersebut, strategi *Developing Personal Skills* adalah sebuah terobosan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya secara mandiri.

Pengembangan keterampilan individu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan hidup sehat, dan penyediaan informasi yang jelas mengenai penyakit serta pencegahannya. Contohnya adalah kampanye edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan olahraga, program penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, serta pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat umum

Secara umum tujuan *Developing Personal Skills* adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar individu dapat: 1) Membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka, 2) Mengadopsi perilaku sehat dan menghindari perilaku berisiko, dan 3) Meningkatkan kemampuan dalam mengelola kondisi kesehatan mereka sendiri. Bentuk riil strategi ini adalah keberadaan program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan kader kesehatan yang salah satu tugasnya adalah memberikan pendidikan dan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya ibu dan anak. Melalui pelatihan dan pendidikan, kader kesehatan ini membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Selain itu dibentuknya kader Tuberkulosis (TBC), dimana pembentukan ini diawali dengan pemberian pelatihan kepada calon kader untuk dapat memahami beberapa teknik komunikasi, dan startegi dalam penemuan suspek sampai pendampingan pengobatan (Fadhilah, 2023). Pelatihan yang dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kader dalam manajemen pasien TBC (Fadhilah, 2023).

Dengan demikian beberapa manfaat dari strategi *Developing Personal Skills* ini diantaranya adalah; 1) Peningkatan Kesehatan Pribadi: Individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik cenderung memiliki status kesehatan yang lebih baik, 2) Pencegahan Penyakit: Dengan pengetahuan yang tepat, individu dapat mengidentifikasi faktor risiko dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai, dan 3) Pemberdayaan: Individu yang terampil merasa lebih berdaya dalam mengelola kesehatan mereka, yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pengembangan keterampilan individu memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang sehat adalah aset bagi negara, karena: Produktivitas: Individu yang sehat lebih produktif, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, Pengurangan Beban Kesehatan: Dengan meningkatnya keterampilan individu dalam menjaga kesehatan, beban pada sistem kesehatan dapat berkurang, dan Peningkatan Kualitas Hidup: Kesehatan yang baik meningkatkan kualitas hidup, yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan.

E. *Reorienting Health Services* (Reorientasi layanan kesehatan)

Reorientasi layanan kesehatan merupakan upaya strategis untuk menekankan pentingnya mengubah fokus sistem layanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek promotif dan preventif, dengan memperkuat layanan primer dan kolaborasi lintas sektor. Strategi ini

bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan, efektif, dan berpusat pada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ketiga yang menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Muhamad, 2023). Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan (Tiraihati, 2017).

Strategi ini mengisyaratkan bahwa, permasalahan kesehatan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah (Kementrian Kesehatan) saja, namun juga harus ada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan melakukan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang dilandasi oleh kesadaran tentang pentingnya sehat. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan mencegah penyakit sebelum terjadi sakit. Namun demikian, implementasi strategi ini bukan persoalan mudah, masih ditemukan berbagai tantangan yang ditemukan di masyarakat, yaitu; 1) Keterbatasan Sumber Daya: Reorientasi memerlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, infrastruktur, dan pendanaan. Keterbatasan ini sering menjadi hambatan dalam implementasi program promotif dan preventif, 2) Resistensi terhadap Perubahan: Perubahan paradigma dari kuratif ke preventif mungkin menghadapi resistensi, baik dari penyedia layanan kesehatan maupun masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan pengobatan setelah sakit, dan 3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dapat menghambat efektivitas program promotif dan preventif.

Langkah konkret reorientasi layanan kesehatan di Indonesia ini tercermin dalam transformasi layanan kesehatan primer yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang fokus pada siklus hidup individu, mendekatkan layanan kesehatan hingga tingkat desa, dan memperkuat pemantauan melalui digitalisasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini mencakup penataan kelembagaan, standarisasi layanan kesehatan, penyediaan sarana prasarana, penguatan sumber daya manusia, dan digitalisasi proses layanan. Integrasi tersebut melibatkan Puskesmas hingga layanan di tingkat desa, dengan tujuan mengurangi angka kesakitan dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Kemenkes RI, 2022).

Bentuk riil implementasi strategi reorientasi adalah Inovasi Program "Si Bina Cantik Bingits" di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto tujuannya untuk mempermudah akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip melayani warga, bukan pelanggan (Hafidzah et al, 2022). Program Home Care di Banjarbaru adalah

betuk implementasi lainnya, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi masyarakat (Bappeda, 2023).

Reorientasi layanan kesehatan berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan melalui: 1) Menurunkan Beban Penyakit: Fokus pada pencegahan dapat mengurangi prevalensi penyakit menular dan tidak menular, 2) Meningkatkan Efisiensi Sistem Kesehatan: Layanan primer yang kuat dapat mengurangi beban pada layanan kesehatan tersier, 3) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Secara Keseluruhan: Dengan pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan determinan sosial Kesehatan, dan 4) Mendukung Capaian SDGs: Terutama dalam tujuan kesehatan yang berkaitan dengan akses universal terhadap layanan kesehatan.

Keberhasilan reorientasi layanan kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan desa, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memastikan bahwa layanan kesehatan yang terintegrasi dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, reorientasi layanan kesehatan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menitikberatkan pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Pemerintah daerah sebuah kota berencana menerapkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan dengan membangun jalur sepeda yang aman dan nyaman, tujuannya mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Apakah prinsip utama yang mencerminkan strategi Building Healthy Public Policy?

- A. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh Masyarakat.
- B. Mengurangi ketidaksetaraan kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan gratis.
- C. Menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dengan regulasi dan inisiatif strategis
- D. Memberikan subsidi biaya kesehatan bagi kelompok rentan
- E. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan obat-obatan esensial

2. Dalam rangka menekan angka penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan "Program skrining kesehatan gratis" yang menawarkan layanan pemeriksaan kesehatan pada hari ulang tahun warga negara.

Apakah manfaat utama dari implementasi kebijakan publik yang mendukung Kesehatan melalui kegiatan screening?

- A. Meningkatkan efektivitas program kesehatan dengan deteksi dini penyakit
 - B. Meningkatkan angka kunjungan pasien ke rumah sakit rujukan
 - C. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada tenaga medis
 - D. Menurunkan anggaran negara dalam sektor Kesehatan
 - E. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan untuk mengurangi antrean pasien.
3. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan publik yang mendukung kesehatan adalah mengatasi ketidaksetaraan kesehatan ini. Apakah langkah kebijakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut
- A. Membangun lebih banyak rumah sakit di daerah perkotaan
 - B. Mewajibkan seluruh tenaga medis untuk bertugas di daerah pedesaan selama 5 tahun
 - C. Meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah pedesaan melalui program layanan kesehatan bergerak
 - D. Memberikan insentif bagi dokter spesialis agar tetap bertugas di rumah sakit besar
 - E. Menekan biaya pengobatan bagi pasien di kota-kota besar
4. Sebuah kota metropolitan menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota berencana menerapkan kebijakan berbasis strategi *Creating Supportive Environments*. Apakah kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks ini?
- A. Meningkatkan ketersediaan rumah sakit dengan layanan spesialis penyakit dalam
 - B. Menyediakan jalur khusus pejalan kaki dan pesepeda serta memperbanyak ruang terbuka hijau
 - C. Memberikan subsidi obat-obatan bagi penderita hipertensi dan diabetes
 - D. Meningkatkan pelatihan tenaga medis di fasilitas kesehatan primer
 - E. Mengadakan kampanye kesehatan melalui media sosial

5. Sebuah sekolah dasar di kota besar mengalami peningkatan kasus obesitas pada siswa akibat pola makan tidak sehat. Kepala sekolah ingin menerapkan konsep *Creating Supportive Environments* untuk mengatasi masalah ini. Apakah Langkah yang paling sesuai dengan strategi tersebut?
- A. Mengadakan seminar kesehatan bagi siswa mengenai pentingnya pola makan sehat
 - B. Mewajibkan siswa mengikuti olahraga setiap pagi sebelum masuk kelas
 - C. Menyediakan kantin sehat dengan menu bergizi dan melarang penjualan makanan tidak sehat
 - D. Memberikan suplemen penurun berat badan bagi siswa yang mengalami obesitas.
 - E. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa setiap bulan
6. Sebuah pusat perbelanjaan di kota besar ingin mendukung kesehatan masyarakat dengan menerapkan konsep *Creating Supportive Environments*. Apakah Kebijakan yang paling sesuai dengan prinsip tersebut?
- A. Menyediakan ruang merokok khusus bagi perokok agar tidak mengganggu pengunjung lain.
 - B. Meningkatkan jumlah eskalator dan lift untuk memudahkan akses ke lantai atas
 - C. Memberikan diskon khusus bagi pembelian produk makanan cepat saji di food court
 - D. Menyediakan jalur pedestrian yang nyaman serta kebijakan bebas rokok di seluruh area mal
 - E. Mengadakan undian berhadiah bagi pengunjung yang sering berbelanja di pusat perbelanjaan
7. Sebuah desa memiliki angka kejadian penyakit diare yang tinggi akibat kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah setempat berencana menerapkan pendekatan *Strengthening Community Action* dengan melibatkan masyarakat dalam program kesehatan berbasis komunitas.
- Apakah strategi yang paling tepat dalam implementasi program tersebut?
- A. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi
 - B. Memberikan bantuan dana langsung kepada masyarakat tanpa adanya pendampingan terkait penggunaannya

- C. Menyediakan layanan kesehatan gratis tanpa melibatkan masyarakat dalam perawatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi
 - D. Mengandalkan peran tenaga kesehatan profesional tanpa melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah sanitasi
 - E. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam program Community-Based Total Sanitation (STBM) guna menciptakan lingkungan yang sehat
8. Sebuah kota, pemerintah bersama organisasi masyarakat merancang program Kampung Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
- Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan prinsip Strengthening Community Action?
- A. Masyarakat hanya menjadi penerima manfaat tanpa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program
 - B. Pemerintah daerah menetapkan aturan wajib bagi masyarakat untuk mengikuti program tanpa adanya konsultasi dengan komunitas
 - C. Masyarakat diberikan kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan kesehatan tanpa adanya koordinasi dengan pihak lain
 - D. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Kampung Germas bersama pemerintah dan organisasi terkait
 - E. Program Kampung Germas dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan organisasi masyarakat setempat
9. Di sebuah desa terpencil, angka kejadian penyakit menular masih tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemerintah setempat bersama tenaga kesehatan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dengan membentuk kader kesehatan, mengadakan pelatihan, serta mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi kesehatan.
- Apakah strategi paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya kesehatan?
- A. Memberikan bantuan langsung berupa obat-obatan dan alat kesehatan kepada warga desa.
 - B. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan di desa mereka.

- C. Menjalankan program kesehatan tanpa melibatkan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
 - D. Mewajibkan setiap warga mengikuti program kesehatan tanpa memberikan edukasi atau sosialisasi sebelumnya.
 - E. Mengandalkan tenaga kesehatan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
10. Seorang ibu rumah tangga di sebuah desa merasa khawatir dengan tingginya angka kejadian penyakit diare di lingkungannya. Ia kemudian mengikuti pelatihan kader kesehatan di Posyandu dan mempelajari cara-cara menjaga kebersihan air dan makanan. Setelah mengikuti pelatihan, ia mulai mengajarkan anggota keluarganya untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar.
- Berdasarkan konsep *Developing Personal Skills*, upaya yang dilakukan ibu tersebut termasuk dalam:
- A. Meningkatkan akses terhadap fasilitas Kesehatan
 - B. Meningkatkan kebijakan publik berbasis Kesehatan
 - C. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas
 - D. Meningkatkan pemberian subsidi untuk pelayanan Kesehatan
 - E. Meningkatkan keterampilan individu dalam mengelola kesehatannya
11. Seorang kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang penemuan suspek TBC berusaha mengedukasi masyarakat di lingkungannya tentang gejala awal TBC dan pentingnya pemeriksaan dini ke fasilitas kesehatan. Apakah tujuan pelatihan tersebut?
- A. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah
 - B. Memberikan layanan pengobatan gratis bagi penderita TBC
 - C. Memberikan pelatihan kepada individu agar mampu mengelola kesehatan secara mandiri
 - D. Mengembangkan teknologi dalam penanganan penyakit menular
 - E. Memfasilitasi penelitian lebih lanjut tentang pencegahan TBC
12. Sebuah daerah dengan angka kejadian penyakit tidak menular yang terus meningkat memutuskan untuk menerapkan strategi reorientasi layanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya promotif dan preventif, serta keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam pendekatan preventif.

Apakah, langkah paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut?

- A. Meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat serta pelatihan tenaga kesehatan dalam upaya promotif dan preventif.
- B. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tersier agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik saat sakit.
- C. Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penyediaan obat-obatan bagi pasien penyakit tidak menular.
- D. Mengubah kebijakan agar hanya pasien dengan kondisi gawat darurat yang dapat mengakses layanan kesehatan.
- E. Meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam menangani penyakit kronis tanpa memperkuat layanan primer.

Soal Essay

1. Jelaskan bagaimana kebijakan publik yang berwawasan kesehatan dapat memengaruhi determinan sosial kesehatan masyarakat.
2. Jelaskan konsep "supportive environment" dan berikan contoh strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat.
3. Berikan contoh program berbasis komunitas yang telah berhasil diterapkan serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya.
4. Jelaskan bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan individu dalam menjaga kesehatannya.
5. Berikan contoh program atau kebijakan yang mendukung reorientasi layanan kesehatan menuju pendekatan yang lebih preventif dan promotif.

G. Kunci Jawaban

No Soal	Kunci Jawaban
1	C
2	A
3	C
4	B
5	C
6	D
7	E
8	D
9	B
10	E
11	C
12	A

H. Rangkuman Materi

Dunia kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi mencegahnya sejak awal. Promosi kesehatan adalah senjata utama dalam perang melawan penyakit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lima strategi utama dalam promosi kesehatan bukan sekadar konsep; melainkan sebuah panggilan aksi bagi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk merombak cara kita memahami dan menangani kesehatan. Secara keseluruhan, kelima pilar promosi kesehatan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi beban penyakit dan ekonomi bagi masyarakat.

Building Healthy Public Policy (Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan), artinya kebijakan yang bertujuan mengintegrasikan aspek kesehatan dalam berbagai sektor kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Manfaatnya meliputi peningkatan kesejahteraan, pengurangan ketidaksetaraan kesehatan, dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Contoh implementasi di Indonesia adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta program skrining kesehatan gratis oleh Kemenkes RI tahun 2025.

Creating Supportive Environments (Menciptakan Lingkungan yang Mendukung); Lingkungan yang mendukung kesehatan melibatkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat. Contohnya adalah kota ramah pejalan kaki dan pesepeda, sekolah sehat, kebijakan bebas rokok, serta pembangunan taman kota dan ruang hijau. Manfaat strategi ini mencakup peningkatan kualitas hidup, pencegahan penyakit, dorongan perilaku sehat, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Strengthening Community Action (Menguatkan Aksi Masyarakat); Pemberdayaan komunitas menjadi kunci keberhasilan program kesehatan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Implementasi di Indonesia terlihat pada program Posyandu, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Kampung Germas. Keberhasilan strategi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Developing Personal Skills (Mengembangkan Keterampilan Individu); Strategi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam menjaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Contoh implementasi adalah pelatihan kader Posyandu dan kader Tuberkulosis (TBC). Manfaatnya termasuk peningkatan kesehatan pribadi, pencegahan penyakit, serta pemberdayaan individu dalam mengelola kesehatan mereka sendiri.

Reorienting Health Services (Reorientasi Layanan Kesehatan); Fokus utama strategi ini adalah mengalihkan sistem layanan kesehatan dari pendekatan kuratif ke promotif dan preventif. Implementasi di Indonesia mencakup transformasi layanan kesehatan primer oleh Kemenkes, yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur kesehatan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit.

I. Glosarium

<i>Creating Supportive Environments</i>	: Strategi dalam promosi kesehatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan individu dan komunitas
Digitalisasi	: Proses mengubah informasi, data, atau aktivitas dari bentuk analog ke format digital agar lebih mudah diakses, diproses, dan disimpan menggunakan teknologi komputer dan internet.
Digitalisasi proses layanan	: Transformasi dari sistem manual atau konvensional ke sistem berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan
<i>Developing Personal Skills</i>	: Mengembangkan Keterampilan Individu
Germas	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Home Care	: Layanan perawatan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumah mereka sendiri, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, mempercepat pemulihan, dan mengurangi kebutuhan rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
Kuratif	: Upaya pengobatan bagi individu yang sudah sakit untuk menghilangkan atau mengurangi gejala penyakit.
Personnel skill	: Keterampilan individu
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Promotif	: Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan pemberdayaan.

Preventif	: Tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya penyakit atau komplikasi.
PIS-PK	: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
<i>Reorienting Health Services</i>	: Reorientasi layanan kesehatan
Rehabilitatif	: Upaya pemulihan agar individu dapat kembali ke kondisi semaksimal mungkin setelah mengalami penyakit atau kecacatan.
Screening	: Proses pemeriksaan atau penapisan untuk mendeteksi adanya suatu kondisi atau penyakit pada individu yang belum menunjukkan gejala.
Sosioekologi	: Suatu pendekatan yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.
<i>Strengthening Community Action</i>	: Pemberdayaan masyarakat agar lebih aktif dalam meningkatkan kesehatan mereka sendiri
STBM	: <i>Program Community-Based Total Sanitation</i>
SDGs	: Sustainable Development Goals
TBC	: Tuberkulosis

J. Daftar Pustaka

- Bappeda (2023) Kspose Akhir Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Menjangkau Seluruh Masyarakat Kota Banjarbaru Melalui Program Home Care. Pemda Banjar baru.
- Fadhilah, (2023). Pendidikan Kesehatan Sebuah Pendekatan/Nilai untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Pencegahan Penularan TB Paru pada anggota Keluarga Kontak Serumah. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Pringsewu.
<https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JIK/article/view/1925>
- Green L.W., & Kreuter, M.W. (2005). *Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill, New York.
- Hafidzah A (2022) Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto: Studi Kasus Program Si Bina Cantik Bingits. <https://doi.org/10.20473/jgar.v3i1.37932>. https://ejournal.unair.ac.id/JGAR/article/view/37932?utm_source=chatgpt.com
- Kemenkes RI (2022). Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (2022) Kementerian integrasikan dan revitalisasi pelayanan keehatan primer (2022)

https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kemenkes-integrasikan-dan-revitalisasi-pelayanan-kesehatan-primer?utm_source=chatgpt.com

Kemenkes RI, (2024). Skrening Kesehatan Gratis Berdasarkan Usia. Kementerian Kesehatan RI; Jakarta. <https://kemkes.go.id/id/skrining-kesehatan-gratis-berdasarkan-usia-hadiah-spesial-setiap-hari-ulang-tahun>

Kemenkes RI, (2018). Kemenkes RI. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Leppo et al, 2013. *Health in All Policies: Seizing Opportunities, Implementing Policies*. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, Finland.

MacDougall & Leeuw (2007). *Healthy Public Policy*. South Melbourne, Australia

Malem,R et al (2022) *Buku Referensi Pendidikan Dan Promosi Kesehatan: Membangun Kebijakan Kesehatan Publik*. Penerbit: Bandar Publishing; Kota Terbit: Banda Aceh

Muhamad S (2023) Menatap Indonesia Emas 2045 melalui Integrasi Layanan Kesehatan Primer. https://www.antaranews.com/berita/3729561/menatap-indonesia-emas-2045-melalui-integrasi-layanan-kesehatan-primer?utm_source=chatgpt.com#google_vignette. Diakses tanggal 6 maret 2025

Nutbeam, D., & Harris, E, 2010). Nutbeam, D., & Harris, E. (2010). *Theory in a Nutshell: A Guide to Health Promotion Theory*. McGraw-Hill, Sydney.

Tiraihati ZW, (2017) Analisis Promosi Kesehatan Berdasarkan Ottawa Charter Di Rs Onkologi Surabaya Health Promotion Hospital Based Ottawa Charter. Jurnal Promkes, Vol. 5, No. 1 Juli 2017: 1–11

World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion. Adopted on 21 November.1986. https://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa_Charter_for_Health_Promotion?utm_source=chatgpt.com. Diakses 4 Maret 2025.

World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion. Adopted on 16 June 2012. https://www.who.int/publications/i/item/ottawa-charter-for-health-promotion?utm_source=chatgpt.comDiakses 10 Maret 2025.

BAB 2

KONSEP DASAR PROMOSI KESEHATAN

Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi kesehatan, melainkan juga mencakup perubahan perilaku, penciptaan lingkungan yang sehat, serta pemberdayaan individu dan komunitas agar mampu menjaga dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip dan konsep dasar promosi kesehatan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan di komunitas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, strategi, prinsip, serta tantangan dalam promosi kesehatan secara komprehensif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup promosi kesehatan.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama promosi kesehatan.
- Menganalisis berbagai strategi yang digunakan dalam promosi kesehatan.
- Menguraikan pendekatan yang diterapkan dalam program promosi kesehatan.
- Menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.

Uraian Materi

A. Definisi Promosi Kesehatan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap kesehatan mereka dan meningkatkan kualitas hidupnya secara menyeluruh. Promosi kesehatan menekankan pada pendekatan yang proaktif, di mana individu tidak sekadar sebagai penerima informasi, melainkan sebagai pelaku aktif dalam menentukan kesehatan mereka sendiri.

Definisi promosi kesehatan menurut WHO tersebut menegaskan bahwa kesehatan bukan semata-mata hasil dari pelayanan medis yang diterima seseorang, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, upaya promosi kesehatan tidak hanya terbatas pada edukasi atau penyebaran informasi, namun lebih pada penguatan keterampilan individu, pemberdayaan komunitas, serta menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat.

Konsep ini melibatkan aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk mengubah perilaku individu, mengembangkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan, serta memperkuat tindakan komunitas dalam menjaga lingkungan yang sehat. Tujuan akhirnya adalah tercapainya perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mempertahankan kesehatannya secara jangka panjang.

Dalam perspektif ini, setiap individu diharapkan mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut mencakup gaya hidup, lingkungan fisik dan sosial, serta kebijakan publik yang mendukung. Oleh karena itu, promosi kesehatan perlu menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan dan aktivitas sosial di masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Promosi Kesehatan

Dalam implementasi promosi kesehatan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipahami, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama yang mendukung keberhasilan promosi kesehatan. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahap program kesehatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Keterlibatan ini memastikan bahwa intervensi kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan partisipasi aktif, masyarakat merasa

memiliki dan bertanggung jawab atas program tersebut, meningkatkan efektivitas dan penerimaan program, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan hasil intervensi.

2. Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan bertujuan memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertindak secara mandiri untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Pemberdayaan meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta akses terhadap informasi dan sumber daya. Proses pemberdayaan melibatkan edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan praktis, serta pemberian dukungan sosial dan sumber daya yang memadai. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mampu mengatasi tantangan kesehatan tetapi juga aktif dalam menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan di lingkungan mereka.

3. Intersektoral

Prinsip intersektoral menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung promosi kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Setiap sektor memiliki peran, tanggung jawab, sumber daya, dan keahlian khusus yang dapat saling melengkapi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kebijakan, infrastruktur, serta lingkungan sosial dan fisik yang mendukung gaya hidup sehat secara optimal.

4. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan merupakan landasan penting agar program promosi kesehatan memiliki dampak jangka panjang. Untuk mencapai keberlanjutan, program kesehatan harus terintegrasi dalam kebijakan publik, sistem kesehatan, dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberlanjutan juga dicapai melalui edukasi berkelanjutan, penguatan kapasitas komunitas, serta evaluasi berkala untuk memastikan program tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan baru. Dengan demikian, promosi kesehatan tidak lagi sekadar intervensi sementara, melainkan menjadi bagian integral dari budaya hidup sehat masyarakat.

C. Strategi Promosi Kesehatan

Dalam implementasi promosi kesehatan, terdapat lima strategi utama yang penting untuk dipahami dan diterapkan secara efektif:

1. Pengembangan Kebijakan Publik Sehat

Pengembangan kebijakan publik sehat merupakan strategi penting yang bertujuan menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara luas. Strategi ini meliputi proses perumusan kebijakan kesehatan yang mencakup peraturan tentang pengendalian penyakit menular, regulasi pangan, kebijakan bebas asap rokok, serta regulasi yang mendorong aktivitas fisik. Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi antar-lembaga pemerintah dan sektor swasta guna memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung

Strategi ini berfokus pada penyediaan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung praktik hidup sehat. Lingkungan fisik yang mendukung dapat berupa pembangunan fasilitas olahraga umum, taman kota, jalan khusus pejalan kaki dan pesepeda, serta area bebas rokok. Sementara itu, lingkungan sosial yang kondusif mencakup promosi norma dan nilai-nilai yang mendukung perilaku hidup sehat, seperti komunitas yang aktif dalam aktivitas fisik rutin dan kebiasaan pola makan sehat. Lingkungan yang kondusif ini berperan penting dalam membantu masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat secara alami dan berkelanjutan.

3. Penguatan Aksi Komunitas

Penguatan aksi komunitas adalah upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang mereka hadapi. Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi intervensi kesehatan mereka sendiri. Melalui kegiatan seperti pelatihan kader kesehatan, program kelompok diskusi, kegiatan gotong royong, dan kampanye kesehatan masyarakat, komunitas dapat membangun solidaritas dan kesadaran kolektif, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan dampak program kesehatan.

4. Pengembangan Keterampilan Individu

Strategi ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan dan pelatihan keterampilan hidup sehat agar individu dapat membuat keputusan kesehatan secara mandiri. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek seperti manajemen stres, keterampilan memasak makanan sehat, pengetahuan tentang nutrisi, dan keterampilan fisik yang relevan seperti teknik olahraga dan aktivitas fisik yang benar. Dengan meningkatkan keterampilan individu, masyarakat dapat menghadapi berbagai tantangan kesehatan dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kesehatan secara mandiri.

5. Reorientasi Pelayanan Kesehatan

Reorientasi pelayanan kesehatan adalah strategi yang bertujuan mengubah paradigma layanan kesehatan dari yang sebelumnya bersifat kuratif (penyembuhan) menjadi preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan). Perubahan ini melibatkan berbagai tindakan seperti edukasi kesehatan preventif, imunisasi rutin, skrining penyakit secara dini, serta promosi gaya hidup sehat yang aktif dilakukan oleh tenaga kesehatan. Strategi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit dan mengurangi beban pelayanan kesehatan di masa depan.

D. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan berfokus pada kondisi lingkungan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Ini mencakup aspek pengelolaan limbah domestik maupun industri, sanitasi dasar, pengelolaan kualitas air bersih, pengendalian kualitas udara, dan pencegahan polusi. Intervensi kesehatan lingkungan juga termasuk upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui edukasi dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi kehidupan manusia.

2. Kesehatan Sekolah

Promosi kesehatan di sekolah bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang optimal siswa. Upaya ini melibatkan peningkatan fasilitas sanitasi seperti toilet bersih dan sarana cuci tangan, program pendidikan kesehatan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, peningkatan akses makanan bergizi di kantin sekolah, serta aktivitas fisik yang rutin dan terstruktur. Program ini juga mencakup pencegahan dan penanganan penyakit menular, serta edukasi kesehatan mental untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa.

3. Kesehatan Kerja

Promosi kesehatan kerja bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerja, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistik. Ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja melalui penerapan prosedur keselamatan kerja, manajemen ergonomi untuk menghindari gangguan muskuloskeletal, program manajemen stres dan kesejahteraan mental, serta promosi gaya hidup sehat seperti aktivitas fisik rutin dan pola makan seimbang.

di lingkungan kerja. Melalui strategi ini, kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja dapat terjamin, meningkatkan produktivitas kerja secara signifikan.

4. Kesehatan Masyarakat

Promosi kesehatan masyarakat melibatkan upaya-upaya komprehensif untuk meningkatkan status kesehatan populasi secara kolektif. Strategi ini mencakup kampanye kesehatan, imunisasi massal, skrining penyakit kronis dan infeksius, intervensi perubahan perilaku kesehatan seperti kampanye antirokok, program edukasi kesehatan reproduksi, dan peningkatan akses layanan kesehatan primer. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

5. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas adalah proses memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu secara mandiri mengenali, menganalisis, serta mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang mereka hadapi. Proses ini mencakup peningkatan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat, pelatihan keterampilan teknis seperti teknik sanitasi lingkungan dan pembuatan makanan sehat, serta peningkatan kapasitas komunitas dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk menciptakan program kesehatan yang berkelanjutan.

6. Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan strategi vital dalam promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terkait isu-isu kesehatan. Metode edukasi meliputi seminar, lokakarya, pelatihan langsung, kampanye media massa maupun media sosial, serta penyuluhan kesehatan secara terstruktur dan berkala. Edukasi kesehatan yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga mampu merubah perilaku individu dan kelompok menuju gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

E. Pendekatan dalam Promosi Kesehatan

Dalam implementasi promosi kesehatan, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat secara efektif:

1. Pendekatan Edukatif

Pendekatan edukatif menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat tentang berbagai isu kesehatan. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan edukasi seperti kampanye kesehatan publik, penyuluhan, seminar, lokakarya, serta penggunaan media informasi seperti brosur, poster, media elektronik, dan media sosial. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya menjaga kesehatan, cara mencegah berbagai penyakit, serta bagaimana mengambil keputusan yang sehat berdasarkan informasi akurat dan jelas. Pendekatan edukatif sangat penting karena memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku berfokus pada intervensi langsung terhadap perilaku individu yang memengaruhi kesehatan secara signifikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu yang berisiko terhadap kesehatan, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan yang tidak sehat, serta gaya hidup sedentari. Metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini antara lain konseling pribadi, kelompok pendukung, pelatihan keterampilan khusus seperti manajemen stres atau teknik berhenti merokok, serta pemberian insentif atau penghargaan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Keberhasilan pendekatan ini dinilai dari perubahan nyata perilaku individu yang berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang.

3. Pendekatan Lingkungan

Pendekatan lingkungan bertujuan menciptakan kondisi fisik dan sosial yang mendukung perilaku sehat secara alami di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencakup pembangunan infrastruktur yang ramah kesehatan, seperti taman bermain, fasilitas olahraga umum, jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Di samping itu, pendekatan ini juga mencakup penciptaan lingkungan sosial yang mendukung, seperti pengembangan norma sosial yang positif terhadap kebiasaan hidup sehat, seperti kawasan bebas rokok, tersedianya makanan sehat di kantin dan lingkungan publik, serta komunitas yang secara aktif mempromosikan kegiatan fisik dan pola hidup sehat. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab kesehatan tidak hanya di tangan individu tetapi merupakan upaya kolektif komunitas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan.

F. Tantangan dalam Promosi Kesehatan

Implementasi promosi kesehatan menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar tujuan akhir peningkatan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Tantangan utama tersebut antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam promosi kesehatan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Banyak masyarakat masih belum memahami dampak jangka panjang dari

kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta perilaku berisiko lainnya. Hal ini terjadi karena terbatasnya akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan edukasi kesehatan yang belum efektif dalam penyampaian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih inovatif, menarik, dan interaktif seperti pemanfaatan media digital, kampanye publik yang kreatif, serta metode penyuluhan berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat agar lebih proaktif menjaga kesehatannya.

2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Manusia

Implementasi promosi kesehatan membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dari segi finansial maupun tenaga manusia. Program-program yang efektif biasanya memerlukan pendanaan besar untuk aktivitas edukasi, pengadaan fasilitas penunjang seperti infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, serta evaluasi secara berkala. Keterbatasan anggaran kesehatan sering menjadi kendala utama, ditambah lagi dengan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang promosi kesehatan. Tantangan ini menuntut kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan teknologi seperti e-health dan m-health juga bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut.

3. Paradigma yang Menekankan Pengobatan daripada Pencegahan

Paradigma kesehatan yang cenderung kuratif, yang lebih menitikberatkan pada pengobatan setelah seseorang sakit dibandingkan dengan pencegahan penyakit, menjadi tantangan yang signifikan dalam promosi kesehatan. Kondisi ini sering tercermin dalam kebijakan pemerintah, alokasi anggaran kesehatan, serta perilaku masyarakat yang baru berusaha mencari solusi setelah mengalami penyakit. Tantangan ini memerlukan perubahan paradigma secara menyeluruh melalui edukasi dan advokasi berkelanjutan agar lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif. Reorientasi pelayanan kesehatan, integrasi promosi kesehatan dalam berbagai kebijakan publik, serta advokasi terhadap pengambil kebijakan adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mengatasi tantangan ini.

G. Latihan Soal

1. Komunitas Desa Melati memiliki tingkat kasus hipertensi yang tinggi. Sebagian besar warga desa kurang menyadari pentingnya menjaga pola makan dan

aktivitas fisik teratur. Sebagai perawat komunitas, strategi utama yang paling tepat digunakan dalam kondisi ini adalah:

- A. Penyediaan fasilitas olahraga umum
- B. Kampanye edukasi melalui media sosial
- C. Penyediaan makanan sehat gratis
- D. Konseling individual intensif
- E. Mengadakan seminar secara rutin di balai desa

Jawaban: b. Kampanye edukasi melalui media sosial

Pembahasan: Strategi edukasi melalui media sosial efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas dan meningkatkan kesadaran tentang hipertensi serta pola hidup sehat secara umum. Strategi ini sesuai dengan prinsip edukatif dalam promosi kesehatan yang menekankan penyampaian informasi secara luas dan efektif.

2. Sebuah perusahaan mencatat tingginya angka pekerja yang mengalami stres kerja. Sebagai perawat perusahaan, pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah:

- A. Menyediakan konseling psikologis rutin
- B. Menambahkan waktu istirahat tambahan setiap hari
- C. Mengurangi jam kerja
- D. Mengadakan kegiatan pelatihan manajemen stres
- E. Memberikan bonus kepada pekerja yang tidak stres

Jawaban: d. Mengadakan kegiatan pelatihan manajemen stres

Pembahasan: Pelatihan manajemen stres merupakan pendekatan perilaku yang efektif dalam memberikan keterampilan khusus kepada pekerja untuk mengelola stres secara mandiri, sehingga mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

3. Di Kelurahan Sejahtera, fasilitas umum untuk aktivitas fisik sangat terbatas. Banyak warga yang mengeluh kesulitan menjalankan gaya hidup aktif. Strategi promosi kesehatan yang paling sesuai untuk kondisi ini adalah:

- A. Edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik
- B. Pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda
- C. Mengadakan lomba lari secara berkala
- D. Memberikan voucher diskon gym kepada warga
- E. Mengadakan penyuluhan kesehatan di balai kelurahan

Jawaban: b. Pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda

Pembahasan: Pendekatan lingkungan dalam promosi kesehatan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan fisik yang mendukung gaya hidup aktif. Pembangunan fasilitas seperti jalur pejalan kaki dan sepeda secara langsung mendukung perilaku sehat masyarakat.

4. Sebuah sekolah ingin meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya merokok. Sebagai perawat sekolah, pendekatan edukasi paling efektif yang dapat dilakukan adalah:
- A. Menegur secara langsung siswa yang merokok
 - B. Memberikan hukuman kepada siswa perokok
 - C. Melakukan kampanye anti-rokok melalui media sosial siswa
 - D. Mengadakan ceramah tentang bahaya rokok oleh perawat
 - E. Membagikan brosur tentang bahaya rokok kepada siswa

Jawaban: c. Melakukan kampanye anti-rokok melalui media sosial siswa

Pembahasan: Pemanfaatan media sosial yang biasa digunakan siswa merupakan pendekatan edukatif yang efektif dan sesuai dengan karakteristik audiens remaja. Kampanye melalui media ini mampu menjangkau lebih banyak siswa dengan pesan yang mudah diterima dan menarik.

5. Pemerintah kota menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan bebas asap rokok di tempat umum karena rendahnya dukungan masyarakat. Prinsip promosi kesehatan yang harus ditekankan untuk mengatasi tantangan ini adalah:
- A. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
 - B. Edukasi intensif tentang bahaya rokok
 - C. Penegakan aturan secara ketat oleh aparat
 - D. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar
 - E. Menambah jumlah papan larangan merokok

Jawaban: a. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Pembahasan: Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan adalah prinsip penting dalam promosi kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mudah diterima dan efektif dalam penerapannya.

H. Rangkuman Materi

Promosi kesehatan adalah proses strategis yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan mereka, sehingga menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik secara menyeluruh. Menurut

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), konsep ini menempatkan individu sebagai aktor aktif yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatannya. Dalam perspektif ini, kesehatan tidak hanya tergantung pada layanan medis, melainkan hasil dari interaksi positif antara individu dan lingkungan sekitarnya. Upaya promosi kesehatan mencakup penguatan keterampilan individu, pemberdayaan komunitas, serta menciptakan kondisi lingkungan sosial dan fisik yang mendukung gaya hidup sehat secara berkelanjutan.

Implementasi promosi kesehatan didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain partisipasi masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif komunitas dalam setiap tahapan kegiatan kesehatan. Pemberdayaan individu dan komunitas bertujuan memperkuat kapasitas mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan mandiri untuk menjaga kesehatan. Prinsip intersektoral menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Prinsip keberlanjutan memastikan bahwa program promosi kesehatan terintegrasi secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan kebijakan publik, sehingga dampaknya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Terdapat berbagai strategi penting dalam promosi kesehatan, yaitu pengembangan kebijakan publik sehat yang mencakup regulasi pendukung kesehatan masyarakat, penciptaan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat secara alami, penguatan aksi komunitas melalui pelatihan dan kegiatan kolaboratif, pengembangan keterampilan individu melalui edukasi kesehatan dan pelatihan praktis, serta reorientasi pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menjadi lebih preventif dan promotif.

Ruang lingkup promosi kesehatan meliputi berbagai aspek penting kehidupan, seperti kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, sanitasi, serta mitigasi dampak perubahan iklim; kesehatan sekolah yang mencakup edukasi kesehatan, sanitasi, nutrisi, dan aktivitas fisik; kesehatan kerja yang berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan pekerja; kesehatan masyarakat yang melibatkan program pencegahan penyakit serta peningkatan kesadaran kolektif; pemberdayaan komunitas melalui peningkatan kapasitas mandiri masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan; serta edukasi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat.

Pendekatan dalam promosi kesehatan terdiri dari pendekatan edukatif yang berfokus pada penyebaran pengetahuan dan kesadaran tentang isu-isu kesehatan,

pendekatan perilaku yang bertujuan mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku sehat melalui intervensi langsung, dan pendekatan lingkungan yang menciptakan kondisi fisik serta sosial yang mendukung perilaku hidup sehat secara alami. Namun demikian, implementasi promosi kesehatan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya finansial serta tenaga kesehatan, serta paradigma yang masih menitikberatkan pada pengobatan dibandingkan pencegahan. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan terpadu, inovasi dalam metode edukasi, pemanfaatan teknologi, serta advokasi yang kuat terhadap kebijakan preventif dan promotif.

I. Glosarium

Promosi Kesehatan: Proses yang memungkinkan masyarakat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Pendekatan Proaktif: Cara berpikir dan bertindak yang mengutamakan pencegahan dan tindakan positif sebelum terjadinya masalah kesehatan.

Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif komunitas dalam seluruh tahapan program kesehatan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Pemberdayaan: Proses memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam mengambil keputusan dan bertindak mandiri dalam meningkatkan kesehatan.

Intersektoral: Kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.

Keberlanjutan: Upaya memastikan bahwa program promosi kesehatan tetap relevan dan efektif secara jangka panjang, terintegrasi dalam kebijakan dan kegiatan masyarakat sehari-hari.

Pengembangan Kebijakan Publik Sehat: Penyusunan regulasi yang mendukung terciptanya lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik yang sehat bagi masyarakat.

Penciptaan Lingkungan yang Mendukung: Upaya menyediakan kondisi fisik dan sosial yang kondusif untuk mengadopsi gaya hidup sehat secara alami.

Penguatan Aksi Komunitas: Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengatasi permasalahan kesehatan melalui kegiatan partisipatif seperti diskusi kelompok, pelatihan kader, dan kampanye kesehatan.

Pengembangan Keterampilan Individu: Pendidikan kesehatan dan pelatihan praktis untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membuat keputusan sehat secara mandiri.

Reorientasi Pelayanan Kesehatan: Perubahan pendekatan dalam pelayanan kesehatan dari yang bersifat kuratif (penyembuhan) menjadi preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan).

Kesehatan Lingkungan: Aspek kesehatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan fisik seperti limbah, air, udara, serta mitigasi dampak perubahan iklim.

Kesehatan Sekolah: Upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa serta staf sekolah.

Kesehatan Kerja: Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja melalui lingkungan kerja yang sehat dan aman serta promosi kesejahteraan pekerja.

Kesehatan Masyarakat: Upaya kolektif yang bertujuan meningkatkan status kesehatan populasi melalui berbagai intervensi kesehatan komunitas.

Edukasi Kesehatan: Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait isu-isu kesehatan melalui berbagai media dan metode edukatif.

Pendekatan Edukatif: Strategi yang mengutamakan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan.

Pendekatan Perilaku: Strategi yang berfokus pada perubahan langsung perilaku individu yang berisiko terhadap kesehatan melalui intervensi khusus.

Pendekatan Lingkungan: Strategi yang menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung perilaku hidup sehat secara alami.

Paradigma Kuratif: Pendekatan kesehatan yang lebih menekankan pada pengobatan setelah munculnya penyakit dibandingkan pencegahan penyakit.

Preventif dan Promotif: Pendekatan dalam kesehatan yang mengutamakan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan melalui intervensi proaktif.

J. Daftar Pustaka

- Edelman, C. L., & Kudzma, E. C. (2017). *Health Promotion Throughout the Life Span* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (2017). *Health Promotion Programs: From Theory to Practice* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (Eds.). (2015). *Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Green, J., Cross, R., Woodall, J., & Tones, K. (2019). *Health Promotion: Planning and Strategies* (4th ed.). Sage Publications.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Laverack, G. (2013). *Health Activism: Foundations and Strategies*. Sage Publications.

- Naidoo, J., & Wills, J. (2016). *Foundations for Health Promotion* (4th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Nutbeam, D., Harris, E., & Wise, M. (2010). *Theory in a Nutshell: A Practical Guide to Health Promotion Theories* (3rd ed.). McGraw-Hill Education Australia.
- Scriven, A. (2017). *Promoting Health: A Practical Guide* (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization. (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion*. Geneva: WHO.

BAB 3

PERENCANAAN PROMOSI KESEHATAN

Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan pendekatan strategis yang bertujuan memberdayakan individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Dalam praktik keperawatan, promosi kesehatan berfungsi sebagai landasan utama dalam intervensi preventif dan edukatif, yang bertujuan tidak hanya mengatasi penyakit tetapi juga mencegah timbulnya masalah kesehatan melalui perubahan perilaku sehat, edukasi kesehatan, serta advokasi kebijakan publik. Buku ini menguraikan konsep dasar promosi kesehatan, teori-teori utama yang mendukung praktik ini, perencanaan, implementasi, evaluasi program, serta studi kasus nyata sebagai pembelajaran praktis di lapangan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar promosi kesehatan secara profesional, etis, dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan komunitas dalam berbagai konteks layanan keperawatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan secara sistematis dengan menggunakan teori, model, serta pendekatan partisipatif berbasis bukti.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan secara komprehensif konsep dasar, tujuan, sejarah, prinsip, dan peran promosi kesehatan dalam konteks keperawatan.
- Menguraikan teori dan model promosi kesehatan, serta aplikasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi kesehatan.
- Menyusun perencanaan promosi kesehatan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan strategi dan media.

- Melaksanakan program promosi kesehatan dengan pendekatan individual, kelompok, dan komunitas, menggunakan teknik komunikasi efektif dan prinsip etika keperawatan.
- Melakukan evaluasi program promosi kesehatan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan dan analisis data, serta mampu menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis.
- Menganalisis dan merefleksikan pembelajaran dari studi kasus dan aplikasi nyata di lapangan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan promosi kesehatan.
- Memberikan rekomendasi praktis berbasis bukti untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang promosi kesehatan di keperawatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Promosi Kesehatan

1. Pengertian Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan mereka melalui upaya pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan lingkungan. Menurut WHO (1986), promosi kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam konteks keperawatan, promosi kesehatan mencakup semua intervensi perawat yang bertujuan mendorong perubahan perilaku sehat, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup pasien maupun masyarakat.

2. Tujuan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan memiliki beberapa tujuan utama:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat
- Mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku sehat.
- Mendorong lingkungan yang mendukung kesehatan.
- Mengurangi beban penyakit melalui pencegahan.
- Meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas.

3. Sejarah dan Perkembangan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan telah mengalami perkembangan paradigma, dari pendekatan individual ke pendekatan komunitas:

Era	Pendekatan	Karakteristik
1900–1950	Edukasi kesehatan	Fokus pada penyuluhan dan informasi
1950–1980	Pencegahan penyakit	Imunisasi, sanitasi, pengobatan dini
1986–sekarang	Pemberdayaan	Melibatkan masyarakat, kebijakan publik

Tonggak sejarah penting adalah *Ottawa Charter for Health Promotion* (1986), yang menetapkan lima aksi promosi kesehatan:

- Membangun kebijakan publik yang sehat
- Menciptakan lingkungan yang mendukung
- Memperkuat aksi komunitas
- Mengembangkan keterampilan individu
- Menyesuaikan pelayanan kesehatan

4. Prinsip dan Nilai Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan berdasarkan pada nilai-nilai:

- Keadilan sosial: Semua orang berhak atas kesempatan hidup sehat.

- b. Pemberdayaan: Individu dan komunitas sebagai subjek, bukan objek.
- c. Partisipasi aktif: Keterlibatan masyarakat dalam proses promosi.
- d. Kemandirian: Mendorong pengambilan keputusan secara sadar.

Prinsip-prinsip ini mendasari perencanaan program agar bersifat inklusif dan berkelanjutan.

5. Peran Promosi Kesehatan dalam Keperawatan

Perawat memainkan peran sentral dalam promosi kesehatan:

- a. Sebagai edukator: Menyampaikan informasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.
- b. Sebagai konselor: Membantu individu memahami pilihan hidup sehat.
- c. Sebagai fasilitator: Menghubungkan pasien dengan sumber daya komunitas.
- d. Sebagai advokat: Memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesehatan publik.

Promosi kesehatan memperluas cakupan praktik keperawatan dari kuratif menjadi preventif dan promotif.

Promosi kesehatan adalah pendekatan strategis dalam keperawatan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas melalui pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan lingkungan. Seorang perawat diharapkan mampu merancang dan melaksanakan program promosi kesehatan dengan berbasis teori, prinsip etis, dan partisipatif.

B. Teori dan Model Promosi Kesehatan

1. Pentingnya Teori dalam Promosi Kesehatan

Teori dalam promosi kesehatan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami perilaku kesehatan, merancang intervensi, dan mengevaluasi program. Penggunaan teori memastikan bahwa strategi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan intervensi.

2. Health Belief Model (HBM)

a. Pengertian

HBM adalah model yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh psikolog sosial untuk memahami mengapa orang tidak mengikuti program pencegahan kesehatan. Model ini menekankan bahwa persepsi individu terhadap risiko dan manfaat akan memengaruhi perilaku kesehatan.

b. Komponen Utama:

- 1) Perceived Susceptibility (Kerentanan)
- 2) Perceived Severity (Keseriusan)
- 3) Perceived Benefits (Manfaat)
- 4) Perceived Barriers (Hambatan) Cues to Action (Pencetus tindakan)

5) Self-Efficacy (Keyakinan diri)

c. Aplikasi dalam Keperawatan

Digunakan dalam edukasi pasien tentang bahaya merokok, pentingnya imunisasi, dan pengelolaan penyakit kronis.

3. Theory of Planned Behavior (TPB)

a. Pengertian

TPB dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1991) sebagai perluasan dari Theory of Reasoned Action. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku adalah prediktor utama dari perilaku tersebut.

b. Komponen:

- 1) Attitude (Sikap terhadap perilaku)
- 2) Subjective Norms (Norma sosial)
- 3) Perceived Behavioral Control (Kendali atas perilaku)

c. Aplikasi dalam Keperawatan

Diterapkan dalam promosi gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, diet, dan kepatuhan pengobatan.

4. Transtheoretical Model (TTM) / Stages of Change

a. Pengertian

Model ini dikembangkan oleh Prochaska dan DiClemente, dan menjelaskan proses perubahan perilaku dalam tahapan.

b. Tahapan Perubahan:

- 1) Pre-contemplation: Belum ada niat berubah
- 2) Contemplation: Mulai mempertimbangkan
- 3) Preparation: Bersiap untuk bertindak
- 4) Action: Mulai melakukan perubahan
- 5) Maintenance: Mempertahankan perubahan
- 6) Relapse (kemunduran): Kembali ke perilaku lama

c. Aplikasi

Digunakan dalam manajemen perilaku merokok, konsumsi alkohol, atau peningkatan aktivitas fisik.

5. PRECEDE-PROCEED Model

a. Pengertian

Model perencanaan program yang dikembangkan oleh Green dan Kreuter, digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi promosi kesehatan secara sistematis.

b. Struktur Model:

- 1) PRECEDE: Diagnosis sosial, epidemiologis, perilaku, dan edukatif
- 2) PROCEED: Implementasi dan evaluasi (proses, dampak, hasil)

c. Aplikasi

Digunakan untuk menyusun program kesehatan berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif.

6. Perbandingan Singkat Model

Tabel 3.1 Perbandingan Singkat Model

Model	Fokus Utama	Kelebihan	Keterbatasan
HBM	Persepsi individu	Sederhana dan banyak digunakan	Kurang memperhatikan pengaruh sosial
TPB	Niat dan kendali diri	Integratif dengan aspek sosial	Asumsi rasionalitas tinggi
TTM	Tahapan perubahan	Sesuai untuk perilaku adiktif	Sulit menentukan tahap secara tepat
PRECEDE-PROCEED	Perencanaan program	Komprehensif dan sistematis	Kompleks dan membutuhkan data lengkap

Model promosi kesehatan menyediakan kerangka ilmiah untuk memahami dan memodifikasi perilaku kesehatan. Pemilihan model yang tepat akan membantu perawat dalam merancang intervensi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik sasaran.

C. Perencanaan Promosi Kesehatan

1. Pengertian Perencanaan Promosi Kesehatan

Perencanaan promosi kesehatan adalah proses sistematis untuk merancang intervensi yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan perubahan perilaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

Perencanaan yang baik harus berbasis bukti (evidence-based), melibatkan masyarakat (community-based), dan memperhatikan sumber daya serta konteks lokal.

2. Tahapan Perencanaan Promosi Kesehatan

a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Kesehatan

- 1) Menggunakan data epidemiologis, survei, wawancara, dan diskusi kelompok.

Contoh: tingginya angka balita dengan gizi buruk di suatu desa.

- 2) Metode: Rapid assessment, focus group discussion (FGD), PRA.

b. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Tujuan harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan Sasaran dibagi menjadi:

- 1) Sasaran umum: Misalnya meningkatkan status gizi balita.
- 2) Sasaran khusus: Misalnya meningkatnya pengetahuan ibu tentang MP-ASI dalam 6 bulan.

c. Penentuan Strategi dan Metode

- 1) Strategi Komunikasi: Edukasi tatap muka, penyuluhan kelompok, media sosial.

- 2) Metode: Ceramah, diskusi, permainan edukatif, demonstrasi.

d. Penyusunan Rencana Kegiatan

- 1) Jadwal pelaksanaan
- 2) Pembagian tugas tim
- 3) Rencana konten edukasi dan media pendukung

e. Penyusunan Anggaran dan Logistik

- 1) Rincian biaya alat, bahan, transportasi, konsumsi, cetak media
- 2) Sumber dana: internal (puskesmas, universitas), eksternal (CSR, hibah)

3. Pengumpulan dan Analisis Data

a. Sumber Data:

- 1) Primer: Wawancara, observasi, kuisioner
- 2) Sekunder: Profil kesehatan puskesmas, laporan Dinas Kesehatan

b. Teknik Analisis:

- 1) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
- 2) Matrik prioritas masalah
- 3) Root Cause Analysis (pohon masalah)

4. Pengembangan Media dan Pesan Promosi

a. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik sasaran:

b. Visual: Poster, leaflet, infografik

c. Audio-visual: Video edukasi, animasi

d. Digital: Media sosial, aplikasi kesehatan

e. Pesan harus memenuhi prinsip KISS:

f. Keep It Short and Simple

- g. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti
- h. Sertakan ajakan bertindak (call to action)

5. Studi Kasus: Perencanaan Program Promosi Gizi Balita

Tabel 3.1 Perencanaan Program Promosi Gizi Balita

Langkah	Contoh Implementasi
Identifikasi masalah	Gizi buruk di Desa X, prevalensi 20%
Penetapan tujuan	Menurunkan angka gizi buruk 5% dalam 6 bulan
Sasaran	Ibu-ibu balita (sasaran langsung)
Strategi	Penyuluhan mingguan dan kunjungan rumah
Media	Leaflet gizi, demo masak MP-ASI
Evaluasi	Pre-test dan post-test pengetahuan ibu

6. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder

- a. Melibatkan tokoh masyarakat, kader, guru, pemuka agama
- b. Kolaborasi dengan puskesmas, PKK, karang taruna
- c. Menumbuhkan rasa kepemilikan agar program berkelanjutan

7. Tantangan dalam Perencanaan Promosi Kesehatan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat
- c. Hambatan budaya dan kepercayaan lokal
- d. Akses informasi yang belum merata
- e. Solusi: Pendekatan partisipatif, advokasi kebijakan, inovasi media.

Perencanaan promosi kesehatan melibatkan tahapan sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga pengembangan strategi dan media. Dalam praktik keperawatan, perawat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator program, dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kolaboratif.

D. Pelaksanaan Promosi Kesehatan

1. Pengertian Pelaksanaan Promosi Kesehatan

Pelaksanaan promosi kesehatan adalah tahap menerapkan rencana yang telah disusun ke dalam tindakan nyata. Tahap ini mencakup pengorganisasian kegiatan, pelibatan masyarakat, penyampaian pesan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Peran perawat pada tahap ini sangat penting sebagai fasilitator, komunikator, dan pelaksana di lapangan.

2. Strategi Implementasi Program

Pelaksanaan program promosi kesehatan memerlukan strategi yang terstruktur dan fleksibel untuk menjawab dinamika lapangan.

- a. Strategi Individual:
 - 1) Konseling tatap muka
 - 2) Edukasi kesehatan pasien rawat jalan
 - 3) Kunjungan rumah
 - b. Strategi Kelompok:
 - 1) Diskusi kelompok kecil (FGD)
 - 2) Kelas ibu hamil, kelas remaja sehat
 - 3) Pelatihan kader kesehatan
 - c. Strategi Komunitas:
 - 1) Kampanye kesehatan
 - 2) Pameran dan bazar kesehatan
 - 3) Festival atau lomba bertema kesehatan
- 3. Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat**
- a. Mengapa penting?
 - 1) Meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program
 - 2) Mengurangi resistensi dari masyarakat
 - 3) Mendukung pembentukan jaringan kerja
 - b. Stakeholder yang Dilibatkan:
 - 1) Tokoh masyarakat dan agama
 - 2) Kader posyandu
 - 3) Guru, perangkat desa
 - 4) Lembaga swadaya masyarakat
 - c. Cara Melibatkan:
 - 1) Sosialisasi program dan tujuan
 - 2) Forum diskusi dan musyawarah desa
 - 3) Penandatanganan komitmen bersama

4. Teknik Komunikasi Efektif dalam Promosi Kesehatan

Komunikasi adalah kunci dalam menyampaikan pesan promosi kesehatan secara tepat dan mudah diterima.

- a. Komunikasi Verbal:
 - 1) Gunakan bahasa lokal yang sopan dan jelas
 - 2) Sesuaikan gaya bicara dengan tingkat pendidikan sasaran
- b. Komunikasi Nonverbal:
 - 1) Kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh
 - 2) Penampilan profesional perawat meningkatkan kredibilitas
- c. Komunikasi Interpersonal dan Kelompok:
 - 1) Gunakan pendekatan empatik dan partisipatif
 - 2) Dorong partisipasi aktif peserta dalam diskusi

5. Etika dalam Pelaksanaan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika profesional:

- a. Persetujuan informasi (informed consent): Peserta harus tahu dan setuju mengikuti kegiatan
- b. Kerahasiaan data pribadi
- c. Tidak memaksakan perubahan perilaku
- d. Menghormati nilai dan budaya lokal
- e. Menjaga integritas dan kejujuran informasi

6. Dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi kegiatan promosi kesehatan penting untuk evaluasi dan tindak lanjut program.

- a. Format Dokumentasi:
 - 1) Laporan kegiatan (narasi dan logistik)
 - 2) Absensi peserta
 - 3) Hasil pre-test dan post-test
 - 4) Dokumentasi foto dan video (dengan izin)
- b. Tujuan Dokumentasi:
 - 1) Sebagai bukti akuntabilitas
 - 2) Dasar untuk perbaikan program selanjutnya
 - 3) Informasi bagi donor atau pemangku kepentingan

7. Studi Kasus Implementasi

Tabel 3.3 Contoh: Program Edukasi Cegah Anemia pada Remaja Putri

Tahapan	Kegiatan
Persiapan	Koordinasi dengan guru dan puskesmas
Pelaksanaan	Penyuluhan interaktif, pembagian leaflet, diskusi anemia
Komunikasi	Gunakan bahasa remaja, humor, ilustrasi visual
Etika	Sampaikan materi dengan sensitif dan inklusif
Dokumentasi	Absensi, kuisisioner sebelum dan sesudah, dokumentasi kegiatan

Pelaksanaan promosi kesehatan memerlukan strategi komunikasi yang efektif, keterlibatan stakeholder, kepatuhan etika, serta dokumentasi yang sistematis. Perawat sebagai pelaksana perlu mengembangkan pendekatan adaptif dan berbasis budaya untuk memastikan pesan diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

E. Evaluasi Program Promosi Kesehatan

1. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai efektivitas suatu program promosi kesehatan. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai, apa saja yang perlu diperbaiki, serta bagaimana program dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

a. Tujuan:

- 1) Menilai keberhasilan program
- 2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
- 3) Menentukan efisiensi penggunaan sumber daya
- 4) Memberikan dasar pengambilan keputusan

b. Manfaat:

- 1) Memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program
- 2) Mendukung pertanggungjawaban (akuntabilitas)
- 3) Menjadi dasar penyusunan program berikutnya
- 4) Menarik dukungan stakeholder dan pendanaan

3. Jenis-Jenis Evaluasi

Tabel 3.4 Jenis-jenis Evaluasi

Jenis Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Fokus
Evaluasi Formatif	Sebelum dan selama program	Kebutuhan, kesiapan, perencanaan
Evaluasi Proses	Saat pelaksanaan	Apakah kegiatan berjalan sesuai rencana
Evaluasi Dampak	Setelah kegiatan	Perubahan perilaku, pengetahuan, sikap
Evaluasi Hasil	Jangka panjang	Status kesehatan, angka kejadian penyakit

4. Indikator Evaluasi

Agar evaluasi objektif, digunakan indikator terukur, seperti:

- a. Indikator Input: Jumlah tenaga, anggaran, media
- b. Indikator Proses: Jumlah penyuluhan, jumlah peserta
- c. Indikator Output: Peningkatan pengetahuan (skor pre–post test)
- d. Indikator Outcome: Penurunan kasus penyakit, peningkatan perilaku sehat

5. Metode Pengumpulan Data Evaluasi

- a. Observasi langsung
- b. Wawancara (individu/kelompok)
- c. Kuisisioner pre–post test
- d. Studi dokumentasi
- e. Umpan balik peserta/kader

6. Analisis dan Interpretasi Data

Data dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif:

- a. Kuantitatif: Skor, persentase, grafik tren
- b. Kualitatif: Narasi, kutipan langsung, studi kasus
- c. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil aktual terhadap tujuan program yang telah ditetapkan.

7. Pelaporan dan Tindak Lanjut

- a. Komponen Laporan Evaluasi:
 - 1) Latar belakang program
 - 2) Tujuan dan indikator
 - 3) Metodologi evaluasi
 - 4) Hasil dan pembahasan
 - 5) Kesimpulan dan rekomendasi
- b. Penyampaian Hasil:
 - 1) Forum masyarakat
 - 2) Presentasi internal puskesmas
 - 3) Laporan tertulis ke dinas kesehatan/donatur
- c. Tindak Lanjut:
 - 1) Revisi program
 - 2) Replikasi ke wilayah lain
 - 3) Penguatan strategi edukasi

8. Studi Kasus Evaluasi Program

Tabel 3.5 Contoh: Evaluasi Program Edukasi Gizi Ibu Hamil

Aspek	Hasil
Input	Tersedia 2 perawat, 100 leaflet, dana Rp 1 juta
Proses	Dilakukan 3 sesi edukasi di 3 dusun
Output	85% peserta meningkat skornya $\geq 20\%$ (post-test)
Outcome	3 bulan kemudian, peningkatan konsumsi makanan bergizi pada 70% ibu hamil (observasi kader)

Evaluasi merupakan bagian penting dari siklus promosi kesehatan. Melalui evaluasi yang sistematis, program dapat dinilai efektivitasnya dan disempurnakan untuk keberlanjutan jangka panjang. Perawat berperan dalam mengumpulkan data, menyusun laporan, dan mengadvokasi perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

F. Studi Kasus dan Aplikasi di Lapangan

1. Tujuan Studi Kasus

Studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran nyata bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi promosi kesehatan diterapkan di lapangan. Ini menjadi jembatan antara teori dan praktik bagi mahasiswa keperawatan agar lebih siap menghadapi situasi di komunitas.

2. Studi Kasus 1: Program Cegah Anemia pada Remaja Putri

a. Latar Belakang

Di SMA X, 40% siswi mengalami anemia ringan. Hal ini memengaruhi konsentrasi belajar dan aktivitas fisik mereka.

b. Perencanaan Program

- 1) Masalah: Kurangnya konsumsi zat besi dan edukasi gizi
- 2) Tujuan: Meningkatkan pengetahuan siswi tentang anemia dan konsumsi tablet tambah darah
- 3) Sasaran: 100 siswi kelas X dan XI
- 4) Metode: Penyuluhan interaktif, media poster, dan lomba poster

c. Pelaksanaan

- 1) Edukasi dilakukan 2 kali selama 2 minggu
- 2) Dibentuk duta kesehatan sekolah
- 3) Disediakan pojok gizi di UKS

d. Evaluasi

- 1) Pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 35%
- 2) 70% siswi mulai mengonsumsi tablet tambah darah secara teratur

3. Studi Kasus 2: Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di SD

a. Latar Belakang

Tingginya angka diare di kalangan siswa kelas rendah di SDN Y.

b. Perencanaan

- 1) Masalah: Tidak tersedia sarana cuci tangan
- 2) Tujuan: Meningkatkan perilaku CTPS
- 3) Strategi: Edukasi dan pembangunan sarana cuci tangan

c. Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi pada guru dan orang tua
- 2) Edukasi melalui lagu, drama, dan lomba poster
- 3) Pemasangan wastafel dan sabun

d. Evaluasi

- 1) Observasi menunjukkan 85% siswa mencuci tangan sebelum makan
- 2) Terjadi penurunan 50% kasus diare dalam 3 bulan

4. **Studi Kasus 3: Kampanye PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Posyandu**

a. Latar Belakang

Masih ditemukan kebiasaan buang air besar sembarangan di Desa Z.

b. Perencanaan

- 1) Masalah: Kurangnya kesadaran PHBS
- 2) Tujuan: Meningkatkan praktik PHBS pada ibu balita
- 3) Strategi: Kampanye dan penyuluhan rutin di posyandu

c. Pelaksanaan

- 1) Mengintegrasikan materi PHBS dalam kegiatan timbang balita
- 2) Kader diberikan pelatihan penyuluhan
- 3) Poster PHBS dipasang di rumah warga

d. Evaluasi

- 1) Survei 3 bulan pasca program menunjukkan 60% keluarga membangun jamban sehat
- 2) Peningkatan pengetahuan ibu sebanyak 45% (dari hasil pre–post test)

5. **Refleksi dan Pelajaran dari Lapangan**

Dari berbagai studi kasus di atas, beberapa hal dapat disimpulkan:

- a. Keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan dukungan lintas sektor.
- b. Penggunaan media yang kreatif dan sesuai usia sasaran meningkatkan efektivitas edukasi.
- c. Monitoring dan evaluasi sederhana namun konsisten dapat memberikan gambaran dampak yang nyata.
- d. Perawat komunitas harus memiliki keterampilan komunikasi, advokasi, dan adaptasi terhadap kondisi lokal.

Studi kasus menunjukkan bahwa promosi kesehatan bukan sekadar teori, melainkan praktik langsung yang berdampak besar bila dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan terencana. Mahasiswa keperawatan diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu ini dalam praktik klinik dan pengabdian masyarakat.

G. Penutup dan Rekomendasi

1. **Penutup**

Promosi kesehatan adalah bagian integral dari praktik keperawatan, terutama di komunitas. Buku ajar ini telah membahas secara sistematis:

- a. Dasar-dasar promosi kesehatan
- b. Peran perawat dalam promosi kesehatan

- c. Tahapan perencanaan program
- d. Strategi pelaksanaan
- e. Evaluasi yang efektif

Studi kasus nyata di lapangan

Proses promosi kesehatan yang efektif harus berbasis data, melibatkan masyarakat, memperhatikan budaya lokal, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Perawat diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga perencana dan evaluator program yang berdaya guna.

2. Rekomendasi

- a. Untuk Mahasiswa Keperawatan:

Tingkatkan kemampuan perencanaan dan komunikasi kesehatan masyarakat sejak dini melalui praktik komunitas, penelitian kecil, dan observasi lapangan.

- b. Untuk Praktisi Keperawatan:

Gunakan pendekatan partisipatif, kreatif, dan berbasis bukti dalam setiap kegiatan promosi kesehatan di masyarakat.

- c. Untuk Institusi Pendidikan:

Integrasikan materi promosi kesehatan dalam pembelajaran berbasis kasus dan praktik klinik komunitas.

- d. Untuk Peneliti:

Lakukan kajian lebih lanjut tentang efektivitas metode dan media promosi kesehatan di berbagai kelompok sasaran.

H. Latihan Soal

1. Di suatu desa, angka kejadian diare sangat tinggi akibat rendahnya kesadaran mencuci tangan pakai sabun (CTPS). Anda sebagai perawat diberi tugas untuk merancang program promosi kesehatan terkait CTPS di desa tersebut. Langkah pertama yang Anda lakukan dalam perencanaan promosi kesehatan adalah:
 - A. Menentukan strategi komunikasi efektif
 - B. Menetapkan tujuan dan sasaran
 - C. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan
 - D. Menyusun rencana kegiatan secara detail
 - E. Melibatkan tokoh masyarakat dalam program

Jawaban: C

Pembahasan:

Tahap awal dalam perencanaan promosi kesehatan adalah identifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan melalui pengumpulan data epidemiologis, survei, wawancara, dan diskusi kelompok.

2. Setelah dilakukan edukasi CTPS di SD Harapan Jaya, Anda menemukan 80% siswa rutin mencuci tangan sebelum makan. Jenis evaluasi yang paling tepat digunakan dalam kasus ini adalah:

- A. Evaluasi Formatif
- B. Evaluasi Proses
- C. Evaluasi Dampak
- D. Evaluasi Hasil
- E. Evaluasi Kuantitatif

Jawaban: C

Pembahasan:

Evaluasi dampak digunakan untuk melihat perubahan perilaku setelah pelaksanaan program, seperti perubahan kebiasaan mencuci tangan pada siswa.

3. Dalam program promosi kesehatan anemia di SMA Bakti Mulia, Anda menggunakan Health Belief Model (HBM). Menurut model tersebut, siswa yang mulai rutin mengonsumsi tablet tambah darah karena mereka merasa anemia akan menurunkan konsentrasi belajar dan aktivitas fisik. Komponen utama HBM yang paling sesuai dengan ilustrasi ini adalah:

- A. Perceived susceptibility (kerentanan)
- B. Perceived severity (keseriusan)
- C. Perceived benefits (manfaat)
- D. Perceived barriers (hambatan)
- E. Self-efficacy (keyakinan diri)

Jawaban: B

Pembahasan:

Perceived severity adalah persepsi individu mengenai seriusnya suatu penyakit atau masalah kesehatan dan konsekuensi yang mungkin terjadi.

4. Anda merancang kegiatan promosi kesehatan di sebuah komunitas yang memiliki budaya lokal kuat. Prinsip etika apa yang paling perlu Anda pertimbangkan dalam pelaksanaan program ini?

- A. Persetujuan informasi (informed consent)
- B. Menjaga kerahasiaan data pribadi
- C. Tidak memaksakan perubahan perilaku
- D. Menghormati nilai dan budaya lokal
- E. Integritas dan kejujuran informasi

Jawaban: D

Pembahasan:

Menghormati nilai dan budaya lokal sangat penting dalam program promosi kesehatan untuk memastikan penerimaan masyarakat dan keberhasilan intervensi.

5. Dalam program promosi kesehatan terkait gizi balita, tim Anda menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Solusi terbaik yang dapat Anda ambil adalah:
- A. Mengurangi frekuensi edukasi tatap muka
 - B. Menghentikan program hingga dana cukup
 - C. Melakukan advokasi kebijakan untuk mencari dukungan tambahan
 - D. Menggunakan media sosial secara eksklusif
 - E. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan

Jawaban: C

Pembahasan:

Advokasi kebijakan diperlukan untuk mendapatkan dukungan tambahan berupa sumber dana dan tenaga sehingga program tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

I. Rangkuman Materi

Promosi kesehatan merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol individu, kelompok, dan komunitas terhadap kesehatannya melalui edukasi, pemberdayaan, dan modifikasi lingkungan. Dalam keperawatan, promosi kesehatan mencakup intervensi yang bertujuan memotivasi perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan masyarakat luas. Promosi kesehatan memiliki tujuan utama meningkatkan kesadaran kesehatan, mengubah perilaku berisiko, menciptakan lingkungan pendukung, mengurangi beban penyakit melalui pencegahan, dan meningkatkan kualitas hidup individu maupun komunitas.

Secara historis, promosi kesehatan berkembang dari pendekatan edukasi kesehatan yang berfokus pada penyuluhan, menuju pendekatan pencegahan penyakit seperti imunisasi dan sanitasi, hingga pendekatan pemberdayaan yang melibatkan kebijakan publik serta partisipasi aktif masyarakat. Perkembangan signifikan terjadi setelah Ottawa Charter tahun 1986 yang menegaskan pentingnya kebijakan sehat, lingkungan pendukung, aksi komunitas, pengembangan keterampilan individu, serta penyesuaian layanan kesehatan.

Promosi kesehatan didasarkan pada prinsip keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek aktif, partisipasi aktif komunitas, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Dalam keperawatan, peran promosi kesehatan diwujudkan

melalui edukasi, konseling individu, fasilitasi akses ke sumber daya komunitas, dan advokasi kebijakan kesehatan. Hal ini menjadikan praktik keperawatan berkembang dari hanya bersifat kuratif menjadi preventif dan promotif.

Dalam implementasinya, promosi kesehatan menggunakan berbagai teori dan model yang memberikan landasan ilmiah untuk intervensi, seperti Health Belief Model (HBM), Theory of Planned Behavior (TPB), Transtheoretical Model (TTM), dan model PRECEDE-PROCEED. Model-model ini membantu memahami perilaku kesehatan, menyusun strategi intervensi yang tepat, serta mengevaluasi efektivitas program yang dilakukan.

Perencanaan promosi kesehatan dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti, dengan tahapan mulai dari identifikasi masalah kesehatan hingga analisis kebutuhan, penentuan tujuan, penetapan strategi komunikasi dan metode edukasi, pengembangan media promosi yang efektif, serta penyusunan anggaran dan logistik. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat dan berbagai stakeholder seperti tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta organisasi lokal menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program.

Pelaksanaan promosi kesehatan membutuhkan strategi adaptif yang sesuai dengan kondisi lapangan, meliputi konseling individu, diskusi kelompok, kampanye komunitas, serta komunikasi yang efektif dengan memperhatikan aspek verbal dan non-verbal. Prinsip-prinsip etika seperti persetujuan informasi, menjaga kerahasiaan, tidak memaksakan perubahan, menghormati budaya lokal, serta integritas informasi juga harus diterapkan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi promosi kesehatan adalah tahap penting yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta menentukan efektivitas penggunaan sumber daya. Evaluasi melibatkan berbagai indikator mulai dari input hingga outcome dan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun laporan dan menjadi dasar dalam memperbaiki atau mereplikasi program di tempat lain.

Melalui berbagai studi kasus nyata, terlihat jelas bahwa keberhasilan program promosi kesehatan sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, dukungan lintas sektor, penggunaan media edukasi yang tepat, serta evaluasi yang konsisten. Mahasiswa keperawatan diharapkan mampu menerapkan konsep ini secara langsung melalui praktik klinik maupun pengabdian masyarakat.

Secara keseluruhan, promosi kesehatan merupakan aspek integral dalam keperawatan, khususnya keperawatan komunitas, yang berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Direkomendasikan agar mahasiswa keperawatan meningkatkan kompetensi dalam perencanaan dan komunikasi

kesehatan sejak dini, sementara praktisi keperawatan diharapkan menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti dalam intervensi kesehatan di komunitas. Institusi pendidikan diharapkan mengintegrasikan materi ini dalam kurikulum, sementara peneliti didorong untuk terus mengeksplorasi efektivitas berbagai metode promosi kesehatan di berbagai kelompok sasaran.

J. Glosarium

Advokasi: Upaya sistematis untuk mendukung atau memperjuangkan kebijakan tertentu, terutama dalam konteks promosi kesehatan yang bertujuan menciptakan kebijakan publik mendukung kesehatan masyarakat.

Evaluasi: Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menilai efektivitas suatu program promosi kesehatan serta memberikan dasar untuk perbaikan selanjutnya.

Health Belief Model (HBM): Model yang menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap risiko kesehatan, manfaat, hambatan, serta keyakinan diri, berperan besar dalam mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang.

Kemandirian: Kemampuan individu atau komunitas untuk mengambil keputusan terkait kesehatan secara sadar dan tanpa tekanan, sebagai salah satu prinsip dalam promosi kesehatan.

Komunikasi Efektif: Penyampaian pesan kesehatan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami, meliputi aspek verbal, nonverbal, interpersonal, serta kelompok untuk mencapai tujuan edukasi kesehatan.

Ottawa Charter for Health Promotion: Dokumen historis dari WHO (1986) yang menjadi dasar perkembangan promosi kesehatan modern dengan lima strategi utama: kebijakan publik sehat, lingkungan pendukung, aksi komunitas, keterampilan individu, serta pelayanan kesehatan yang adaptif.

Partisipasi Aktif: Prinsip bahwa masyarakat bukan hanya menerima, tetapi aktif terlibat dalam seluruh tahapan promosi kesehatan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Pemberdayaan: Proses meningkatkan kemampuan individu atau komunitas dalam mengelola kesehatan mereka sendiri, mengubah posisi mereka dari objek menjadi subjek aktif dalam intervensi kesehatan.

Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based): Penggunaan data ilmiah atau hasil penelitian terbaru sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program promosi kesehatan.

Pendekatan Partisipatif: Strategi yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat atau sasaran program dalam semua tahapan, demi memastikan relevansi dan keberlanjutan intervensi kesehatan.

Perceived Barriers (Hambatan yang Dirasakan): Persepsi individu mengenai hambatan yang menghalangi mereka dalam melakukan perilaku kesehatan tertentu, bagian dari komponen Health Belief Model.

Perceived Benefits (Manfaat yang Dirasakan): Persepsi individu terhadap keuntungan atau manfaat yang akan didapat jika mereka melakukan perilaku kesehatan tertentu, bagian dari komponen Health Belief Model.

Perceived Severity (Keseriusan yang Dirasakan): Tingkat persepsi individu tentang keseriusan dari suatu masalah atau kondisi kesehatan yang mungkin dialaminya, bagian dari komponen Health Belief Model.

Perceived Susceptibility (Kerentanan yang Dirasakan): Persepsi individu mengenai risiko dirinya untuk mengalami suatu kondisi atau masalah kesehatan, bagian dari komponen Health Belief Model.

PRECEDE-PROCEED Model: Model komprehensif dan sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi promosi kesehatan berbasis komunitas, dengan pendekatan diagnosis sosial hingga evaluasi hasil.

Promosi Kesehatan: Proses pemberdayaan individu dan komunitas melalui pendidikan, perubahan lingkungan, dan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Strategi Implementasi: Pendekatan yang sistematis dan terencana dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lapangan, seperti melalui konseling individual, kelompok kecil, atau kampanye komunitas.

Teori dalam Promosi Kesehatan: Kerangka ilmiah yang digunakan sebagai landasan dalam memahami perilaku kesehatan, merancang intervensi, serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan.

Theory of Planned Behavior (TPB): Teori yang menjelaskan bahwa niat individu dalam melakukan suatu perilaku kesehatan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma sosial, dan persepsi terhadap kendali diri.

Transtheoretical Model (TTM): Model yang menggambarkan perubahan perilaku melalui tahapan spesifik, dari tahap belum memiliki niat berubah hingga tahap mempertahankan perubahan tersebut secara konsisten.

K. Daftar Pustaka

- Allender, J.A., Rector, C., & Warner, K.D. (2014). *Community & Public Health Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Depkes RI. (2009). *Pedoman Umum Promosi Kesehatan di Indonesia*.
- Effendy, C. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Glanz, K., Rimer, B.K., & Viswanath, K. (Eds.). (2015). *Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (5th ed.). Jossey-Bass.

- Green, L.W., & Kreuter, M.W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach* (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kemenkes RI. (2020). *Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Promkes dan PM.
- Maryani, E., & Suharti, S. (2021). Media Promosi Kesehatan Berbasis Digital. *Jurnal Promkes*, 9(2), 110–117.
- Nasution, F. (2018). Evaluasi Program Promosi Kesehatan di Sekolah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 45–53.
- Notoatmodjo, S. (2022). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., & Hall, A.M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2016). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (9th ed.). St. Louis: Elsevier.
- WHO. (2021). *Health Promotion Glossary*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion*. WHO.

BAB 4

APLIKASI PROMOSI KESEHATAN DALAM ASUHAN KEPERAWATAN PADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK

Pendahuluan

Promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan merupakan pendekatan yang integral dalam meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan kelompok secara efektif. Asuhan keperawatan tidak hanya berorientasi pada tindakan kuratif, tetapi juga menitikberatkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi, pemberdayaan, serta intervensi kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing populasi sasaran. Dengan pendekatan promosi kesehatan, perawat dapat membantu individu, keluarga, dan kelompok untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka secara langsung maupun tidak langsung.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep dan strategi promosi kesehatan secara efektif dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok di komunitas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan secara komprehensif, mencakup individu, keluarga, dan kelompok, untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesehatan secara berkelanjutan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan.

- Menganalisis strategi promosi kesehatan yang efektif dalam asuhan keperawatan individu.
- Menerapkan pendekatan promotif dalam asuhan keperawatan pada keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara holistik.
- Mengidentifikasi kebutuhan khusus kelompok dalam komunitas serta merancang program promosi kesehatan yang relevan dan berkelanjutan.

Uraian Materi

A. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Individu

1. Strategi Edukasi Interaktif

Strategi edukasi interaktif yang digunakan dalam promosi kesehatan pada individu menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mencakup dialog dua arah antara perawat dan pasien, serta metode edukasi seperti diskusi terbuka, demonstrasi langsung, video edukasi, dan simulasi peran. Edukasi ini bertujuan agar pasien dapat dengan mudah mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebagai contoh, pasien dengan hipertensi akan menerima edukasi khusus mengenai pentingnya pengendalian tekanan darah, metode pemantauan tekanan darah mandiri, serta strategi untuk mengelola gaya hidup sehat seperti diet rendah garam, aktivitas fisik teratur, dan teknik manajemen stres.

2. Konseling Personal untuk Perubahan Perilaku

Perawat secara aktif melakukan konseling personal yang bertujuan membantu pasien mengenali faktor risiko kesehatan serta menentukan langkah-langkah konkret menuju perubahan perilaku positif. Konseling ini berlangsung dalam suasana empati, kepercayaan, dan dorongan positif, yang memungkinkan pasien untuk terbuka dalam menyampaikan hambatan dan tantangan yang mereka alami.

Dalam sesi konseling, perawat membantu pasien merancang tujuan-tujuan kecil yang realistis serta menyusun rencana tindakan secara bertahap. Sebagai contoh, pasien yang memiliki kebiasaan merokok akan dibimbing melalui tahapan pengurangan konsumsi rokok secara bertahap hingga benar-benar berhenti, dengan bantuan metode coping strategies yang sesuai.

3. Pelatihan Keterampilan Praktis

Pelatihan keterampilan praktis menjadi komponen utama dalam memastikan pasien tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan kesehatan secara nyata dalam kesehariannya. Perawat mempraktikkan teknik-teknik spesifik seperti:

- a. Manajemen Stres: Pasien diajarkan berbagai teknik manajemen stres, seperti meditasi mindfulness, pernapasan dalam, yoga sederhana, dan teknik relaksasi otot progresif. Demonstrasi diikuti oleh latihan mandiri oleh pasien untuk memastikan kemampuan praktisnya.
- b. Pola Makan Sehat: Edukasi nutrisi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip diet seimbang, pemilihan jenis makanan sehat, pengaturan porsi makan, dan metode memasak yang sehat. Perawat seringkali menggunakan metode

praktik langsung, seperti workshop memasak sehat atau sesi konsultasi personal mengenai menu makanan harian.

- c. Aktivitas Fisik Teratur: Pasien diarahkan pada jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Edukasi mencakup demonstrasi jenis latihan yang aman, intensitas latihan yang tepat, serta metode pemantauan aktivitas fisik secara mandiri menggunakan teknologi wearable atau catatan harian aktivitas.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi berkala merupakan bagian integral dari aplikasi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan individu. Perawat mengukur kemajuan pasien melalui wawancara terstruktur, observasi langsung, dan evaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa pasien tetap termotivasi, mendukung keberhasilan jangka panjang dari perubahan perilaku positif yang diupayakan.

Tindak lanjut juga melibatkan pemberian umpan balik yang konstruktif dan dukungan berkelanjutan dari perawat, sehingga pasien merasa didampingi dalam setiap tahap menuju pencapaian tujuan kesehatannya.

B. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Keluarga

Dalam asuhan keperawatan keluarga, promosi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya secara kolektif. Intervensi ini bertujuan tidak hanya mengatasi masalah kesehatan individual tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam lingkungan keluarga secara keseluruhan. Perawat bertindak sebagai edukator, mediator, serta pendukung yang membantu keluarga mengembangkan kapasitas untuk menjalankan gaya hidup sehat yang berkelanjutan.

1. Strategi Edukasi Kesehatan Keluarga

Edukasi keluarga merupakan elemen penting dalam aplikasi promosi kesehatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Perawat mengimplementasikan strategi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik keluarga, menggunakan metode yang interaktif seperti diskusi kelompok keluarga, demonstrasi langsung, simulasi, dan media audio-visual.

Contohnya, keluarga dengan riwayat diabetes mellitus akan menerima edukasi tentang pengaturan pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik rutin, serta cara pemantauan kadar gula darah secara mandiri. Edukasi tersebut didesain agar mudah dipahami dan praktis, sehingga anggota keluarga dapat saling mendukung dalam menerapkannya sehari-hari.

2. Deteksi Dini dan Pencegahan

Asuhan keperawatan keluarga juga berfokus pada upaya deteksi dini masalah kesehatan melalui pemeriksaan rutin serta pemantauan tanda-tanda awal gangguan kesehatan. Perawat melatih keluarga dalam mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan umum seperti hipertensi, obesitas, atau penyakit menular.

Keluarga dibimbing untuk melakukan skrining sederhana di rumah seperti pengukuran tekanan darah, pengecekan berat badan secara rutin, serta mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan lainnya. Dengan demikian, keluarga dapat segera mengambil tindakan pencegahan sebelum kondisi kesehatan anggota keluarga memburuk.

3. Pengelolaan Penyakit Kronis

Bagi keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, perawat memberikan intervensi khusus untuk meningkatkan keterampilan keluarga dalam mengelola kondisi kesehatan tersebut. Intervensi ini mencakup edukasi tentang manajemen pengobatan, perawatan diri yang efektif, pemantauan rutin, serta strategi adaptasi gaya hidup yang sehat.

Keluarga diajarkan teknik praktis, seperti pemberian insulin secara mandiri, menyiapkan makanan sehat yang sesuai kebutuhan pasien, serta teknik manajemen stres yang membantu mengurangi dampak emosional akibat penyakit kronis.

4. Penguatan Dukungan Sosial dalam Keluarga

Dukungan sosial yang kuat antar anggota keluarga menjadi landasan penting dalam promosi kesehatan keluarga. Perawat memfasilitasi keluarga untuk memperkuat komunikasi yang terbuka, membangun hubungan emosional yang sehat, serta meningkatkan kemampuan untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan kesehatan.

Keluarga juga didorong untuk menciptakan suasana rumah yang hangat, aman, dan kondusif untuk kesehatan mental serta emosional seluruh anggota keluarga. Kegiatan seperti diskusi keluarga rutin, pembagian peran secara jelas dalam menjaga kesehatan, serta kegiatan rekreasi bersama menjadi bagian dari strategi ini.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dan tindak lanjut rutin dilakukan oleh perawat untuk menilai efektivitas promosi kesehatan keluarga. Metode evaluasi mencakup wawancara dengan keluarga, pengamatan langsung di rumah, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan kesehatan keluarga.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik konstruktif dan mendukung keluarga dalam menjaga konsistensi perilaku sehat yang telah terbentuk. Tindak lanjut ini memastikan bahwa keluarga tetap memiliki motivasi tinggi untuk terus menjaga dan meningkatkan kesehatan anggotanya.

C. Aplikasi Promosi Kesehatan dalam Asuhan Keperawatan Kelompok

Dalam asuhan keperawatan kelompok, promosi kesehatan diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah kesehatan secara kolektif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemampuan komunitas untuk mengambil keputusan bersama terkait kesehatan mereka. Dalam konteks ini, perawat berperan aktif sebagai fasilitator, edukator, serta penggerak utama yang mendukung komunitas mencapai tujuan kesehatan bersama.

1. Strategi Penguatan Kapasitas Komunitas

Strategi penguatan kapasitas komunitas dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yang mendorong anggota komunitas berperan aktif dalam proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, serta perancangan solusi dan intervensi kesehatan yang relevan. Perawat bertugas memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas secara efektif.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan kader kesehatan: Menyediakan pelatihan intensif bagi kader lokal mengenai pengetahuan kesehatan dasar, komunikasi efektif, serta metode pemantauan dan edukasi kesehatan masyarakat.
- b. Workshop keterampilan hidup sehat: Mengajarkan anggota komunitas keterampilan praktis seperti sanitasi, nutrisi seimbang, dan aktivitas fisik.
- c. Kelompok diskusi interaktif: Menjadi forum komunikasi terbuka di mana komunitas berbagi informasi, pengalaman, dan solusi bersama terkait masalah kesehatan.
- d. Kampanye kesehatan terencana: Menggunakan berbagai pendekatan kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perilaku hidup sehat.

2. Pelatihan Kader Kesehatan

Pelatihan kader kesehatan merupakan elemen penting dalam strategi promosi kesehatan di komunitas. Kader kesehatan yang terlatih bertindak sebagai ujung tombak penyebaran informasi kesehatan, mendukung intervensi lokal, serta menghubungkan komunitas dengan fasilitas kesehatan formal. Perawat memberikan pelatihan mendalam yang meliputi:

- a. Pengetahuan dasar tentang penyakit umum dan pencegahannya

- b. Teknik komunikasi efektif dalam menyampaikan informasi kesehatan
- c. Keterampilan melakukan skrining sederhana seperti pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan dasar lainnya
- d. Metode edukasi komunitas yang praktis dan relevan

Dengan kemampuan ini, kader kesehatan dapat melakukan tugas seperti edukasi kelompok kecil, pendampingan individu dengan kondisi kesehatan tertentu, serta menjadi fasilitator utama kegiatan komunitas.

3. **Kelompok Diskusi dan Partisipasi Aktif**

Kelompok diskusi menjadi sarana utama dalam mendorong partisipasi aktif komunitas. Dalam diskusi ini, anggota komunitas belajar secara langsung mengenai pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Diskusi kelompok difasilitasi oleh perawat yang berfungsi untuk memandu komunitas dalam mengidentifikasi permasalahan kesehatan, mengeksplorasi solusi, serta merancang rencana aksi yang jelas.

Kegiatan yang muncul dari diskusi ini meliputi:

- a. Program gotong royong untuk membersihkan lingkungan
- b. Kampanye kebersihan dan sanitasi lingkungan
- c. Program vaksinasi masal dan kegiatan skrining kesehatan

4. **Kegiatan Gotong Royong dan Kampanye Kesehatan**

Gotong royong merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di komunitas. Kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan, meningkatkan kesadaran kolektif, serta mempercepat pencapaian tujuan kesehatan yang telah ditetapkan. Perawat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ini agar memberikan dampak yang maksimal.

Kampanye kesehatan dirancang dengan pendekatan kreatif, termasuk lomba kebersihan lingkungan, kompetisi olahraga, pertunjukan seni bertema kesehatan, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak anggota komunitas.

5. **Evaluasi dan Monitoring Partisipatif**

Evaluasi dan monitoring dalam promosi kesehatan kelompok dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana komunitas secara aktif terlibat dalam menilai keberhasilan program. Metode evaluasi mencakup survei, diskusi reflektif, serta pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku komunitas.

Data evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut, mempertahankan motivasi komunitas, serta memastikan keberlanjutan hasil positif yang telah dicapai.

D. Latihan Soal

1. Seorang wanita berusia 48 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan sering merasa cemas. Sebagai perawat, pendekatan edukasi interaktif yang paling tepat untuk membantu Ibu Siti mengelola stres dan tekanan darahnya adalah:
 - A. Menyarankan membaca brosur kesehatan
 - B. Memberikan ceramah singkat
 - C. Menggunakan video edukasi disertai demonstrasi teknik pernapasan dalam
 - D. Menyarankan obat antihipertensi saja
 - E. Memberikan nasihat singkat tentang stres

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Pendekatan interaktif seperti penggunaan video edukasi dan demonstrasi langsung lebih efektif karena melibatkan pasien secara aktif dalam proses pembelajaran, membantu mereka memahami dan mengaplikasikan teknik secara nyata.

2. Seorang pria ingin berhenti merokok tetapi sering gagal. Dalam konseling personal, langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah:
 - A. Menginstruksikan langsung berhenti total
 - B. Menghindari pembicaraan tentang hambatan
 - C. Mengajak diskusi terbuka tentang hambatan yang dialami
 - D. Memberikan hukuman jika gagal
 - E. Mengabaikan kebiasaan tersebut

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Diskusi terbuka dalam suasana empati membantu pasien mengenali hambatan dan tantangan, sehingga pasien dapat menemukan solusi realistis dan efektif untuk perubahan perilakunya secara bertahap.

3. Dalam promosi kesehatan keluarga, seorang anggota keluarga didiagnosis diabetes mellitus. Perawat sebaiknya memberikan edukasi yang melibatkan:
 - A. Hanya pasien tersebut saja
 - B. Kepala keluarga saja
 - C. Semua anggota keluarga secara interaktif
 - D. Tetangga dekat keluarga
 - E. Pihak puskesmas saja

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Edukasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga secara interaktif meningkatkan dukungan sosial, pemahaman kolektif, dan kerjasama dalam menjalankan gaya hidup sehat.

4. Dalam kegiatan gotong royong yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan, peran utama perawat yang paling tepat adalah:
- A. Melaksanakan sendiri semua kegiatan
 - B. Menentukan semua keputusan secara mandiri
 - C. Bertindak sebagai fasilitator kegiatan
 - D. Mengabaikan masukan komunitas
 - E. Tidak terlibat langsung dalam kegiatan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Peran perawat sebagai fasilitator mendorong partisipasi aktif komunitas, membantu mereka mengenali masalah, mengambil keputusan bersama, serta merancang kegiatan secara efektif.

5. Evaluasi partisipatif dalam promosi kesehatan kelompok bertujuan utama untuk:
- A. Mengumpulkan data statistik semata
 - B. Menentukan keputusan sepihak oleh perawat
 - C. Menghilangkan peran komunitas dalam evaluasi
 - D. Melibatkan komunitas dalam menilai keberhasilan kegiatan
 - E. Mengabaikan umpan balik dari komunitas

Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Evaluasi partisipatif melibatkan komunitas secara aktif dalam menilai hasil kegiatan, memastikan umpan balik yang konstruktif, meningkatkan rasa kepemilikan, dan keberlanjutan program kesehatan.

E. Rangkuman Materi

Aplikasi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan berfokus pada pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara berkelanjutan. Dalam asuhan individu, perawat menerapkan edukasi interaktif yang melibatkan pasien secara aktif, dengan metode seperti diskusi, demonstrasi langsung, dan simulasi peran untuk membantu pasien memahami dan menerapkan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Konseling personal juga menjadi komponen penting, di mana perawat membimbing pasien dalam mengenali risiko kesehatan dan menentukan langkah-langkah perubahan perilaku secara bertahap. Pelatihan keterampilan praktis seperti manajemen stres, pola makan sehat, dan aktivitas fisik rutin diselenggarakan secara

sistematis agar pasien mampu menerapkan keterampilan tersebut secara mandiri. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perubahan perilaku pasien.

Dalam konteks keluarga, promosi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya secara kolektif. Edukasi kesehatan keluarga dilakukan melalui strategi interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan media audio-visual. Perawat juga melatih keluarga dalam deteksi dini masalah kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pengenalan tanda-tanda gangguan kesehatan secara sederhana di rumah. Intervensi khusus diberikan untuk keluarga dengan anggota yang memiliki penyakit kronis, mencakup pengelolaan pengobatan, perawatan diri, dan adaptasi gaya hidup sehat. Dukungan sosial antar anggota keluarga diperkuat melalui komunikasi terbuka dan kegiatan bersama, yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan fisik dan emosional. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas intervensi dan memberikan umpan balik konstruktif demi menjaga konsistensi perilaku sehat.

Dalam asuhan keperawatan kelompok, promosi kesehatan berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan secara kolektif. Strategi partisipatif digunakan agar anggota komunitas aktif dalam menentukan prioritas dan solusi kesehatan yang relevan. Perawat memfasilitasi berbagai kegiatan seperti pelatihan kader kesehatan, kelompok diskusi interaktif, workshop keterampilan hidup sehat, dan kampanye kesehatan kreatif. Pelatihan kader kesehatan mempersiapkan individu untuk menjadi fasilitator utama dalam edukasi kesehatan masyarakat dan kegiatan pendampingan di komunitas. Kegiatan seperti gotong royong dan kampanye kesehatan dirancang untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial. Evaluasi dan monitoring partisipatif dilakukan untuk memastikan efektivitas program, dengan melibatkan komunitas dalam proses penilaian dan penentuan langkah tindak lanjut untuk mempertahankan keberlanjutan dampak positif yang telah dicapai.

F. Glosarium

Aktivitas Fisik Teratur: Rangkaian kegiatan atau latihan yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik dan kesehatan secara keseluruhan.

Asuhan Keperawatan Individu: Perawatan kesehatan yang dipersonalisasi oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap pasien secara individual.

Asuhan Keperawatan Keluarga: Pendekatan keperawatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk meningkatkan kesehatan secara kolektif dan mengatasi masalah kesehatan bersama.

Asuhan Keperawatan Kelompok: Pendekatan keperawatan yang melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat dalam mengatasi isu kesehatan secara kolektif dengan menekankan pada partisipasi aktif anggota kelompok.

Deteksi Dini: Proses mengidentifikasi tanda atau gejala penyakit sejak awal, untuk memungkinkan intervensi yang cepat dan efektif sebelum kondisi memburuk.

Dialog Dua Arah: Komunikasi interaktif antara dua pihak, seperti antara perawat dan pasien, di mana keduanya aktif bertukar informasi.

Evaluasi Berkala: Penilaian yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan atau efektivitas suatu intervensi atau program kesehatan.

Edukasi Interaktif: Metode pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif melalui dialog, diskusi, demonstrasi, atau simulasi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan praktis.

Gotong Royong: Kerja sama kolektif yang dilakukan oleh anggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam konteks kesehatan komunitas.

Kader Kesehatan: Individu yang telah mendapat pelatihan khusus untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, melakukan edukasi kesehatan, dan membantu proses pemantauan kesehatan di tingkat komunitas.

Kampanye Kesehatan: Upaya sistematis yang menggunakan berbagai media atau pendekatan kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan tertentu dan mendorong perubahan perilaku sehat.

Konseling Personal: Proses interaksi antara perawat dengan pasien secara pribadi untuk membantu pasien memahami masalah kesehatan, mengidentifikasi solusi, dan mendukung perubahan perilaku menuju kesehatan yang lebih baik.

Manajemen Stres: Teknik-teknik tertentu yang diajarkan kepada individu untuk membantu mereka mengendalikan stres, seperti meditasi mindfulness, pernapasan dalam, yoga sederhana, atau relaksasi otot progresif.

Monitoring Partisipatif: Proses pemantauan yang melibatkan anggota komunitas secara aktif dalam mengevaluasi program atau intervensi kesehatan yang dilakukan di komunitas mereka.

Pelatihan Keterampilan Praktis: Program pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan nyata kepada pasien atau anggota komunitas agar dapat langsung menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan Penyakit Kronis: Strategi yang melibatkan edukasi, pemantauan, dan dukungan khusus untuk individu dan keluarga dalam menangani penyakit jangka panjang seperti diabetes atau hipertensi.

Promosi Kesehatan: Proses pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan agar mampu membuat keputusan sehat dan mempertahankan gaya hidup sehat secara berkelanjutan.

Strategi Penguatan Kapasitas Komunitas: Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan secara mandiri melalui partisipasi aktif dan kolaborasi.

Teknik Relaksasi Otot Progresif: Metode relaksasi yang melibatkan kontraksi dan relaksasi bertahap dari kelompok otot untuk mengurangi stres dan meningkatkan rasa tenang.

Teknologi Wearable: Perangkat elektronik yang dikenakan di tubuh, seperti jam tangan pintar, untuk memantau aktivitas fisik dan kondisi kesehatan individu.

Tindak Lanjut: Langkah-langkah lanjutan yang dilakukan setelah evaluasi untuk memastikan tujuan kesehatan tetap tercapai, dengan memberikan dukungan tambahan dan koreksi jika diperlukan.

G. Daftar pustaka

- Adib-Hajbaghery, M., & Tahmouresi, M. (2018). Nurse–patient communication: A review of the literature. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 23(2), 78–83. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_26_17
- Anderson, R. M., & Funnell, M. M. (2018). Patient empowerment: Myths and misconceptions. *Patient Education and Counseling*, 101(6), 1056–1060. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.02.026>
- Bayuo, J. (2018). Nurses' experiences of caring for patients with chronic conditions: An integrative review. *Nursing Open*, 5(4), 520–528. <https://doi.org/10.1002/nop2.158>
- Bekhet, A. K., & Garnier-Villarreal, M. (2018). Family caregiving: Stressors and resources. *Western Journal of Nursing Research*, 40(7), 1010–1036. <https://doi.org/10.1177/0193945917697225>
- Boland, L., Graham, I. D., Légaré, F., Lewis, K. B., Jull, J., Shephard, A., & Stacey, D. (2019). Barriers and facilitators of pediatric shared decision-making: A systematic review. *Implementation Science*, 14(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s13012-018-0851-5>
- Farrance, C., Tsofliou, F., & Clark, C. (2016). Adherence to community-based group exercise interventions for older people: A mixed-methods systematic review. *Preventive Medicine*, 87, 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.02.037>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). *Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (5th ed.). Jossey-Bass.

- Hickey, G., Brearley, S., Coldham, T., Denegri, S., Green, G., Staniszevska, S., & Tembo, D. (2018). Guidance on co-producing a research project. *INVOLVE*. Retrieved from https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/Copro_Guidance_Feb19.pdf
- Langford, R., Bonell, C., Jones, H., & Campbell, R. (2015). Obesity prevention and the health promoting schools framework: Essential components and barriers to success. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0167-7>
- Nouri, S. S., & Rudd, R. E. (2015). Health literacy in the "oral exchange": An important element of patient-provider communication. *Patient Education and Counseling*, 98(5), 565–571. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.01.014>
- Park, Y. H., Chang, H., Kim, J., & Kwak, J. S. (2019). Patient-tailored self-management intervention for older adults with hypertension. *Journal of Clinical Nursing*, 28(3–4), 468–479. <https://doi.org/10.1111/jocn.14686>
- Rodriguez, J., Applebaum, A. J., Stephenson, K. R., Penedo, F. J., & Garcia, S. F. (2019). Quality of life and symptom burden in informal caregivers: A review of assessment instruments. *Journal of Pain and Symptom Management*, 57(4), 722–733. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.12.348>
- Sidani, S., & Epstein, D. R. (2016). *Intervention Design: Theory to Practice*. SAGE Publications.
- Snyder, C. R., Lopez, S. J., Edwards, L. M., & Marques, S. C. (2019). *The Oxford Handbook of Positive Psychology* (3rd ed.). Oxford University Press.
- World Health Organization. (2018). *Family Health and Primary Care*. Retrieved from https://www.who.int/family_health/en/

BAB 5

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Pendahuluan

PHBS Tidak jarang istilah PHBS terdengar di masyarakat. Jika dilihat dari kepanjangannya yakni Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, tentu kita langsung mengetahui apa itu PHBS, singkat kata mengenai perilaku seseorang menyangkut kebersihan yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu burung, atau pun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Dua istilah penting dalam kesehatan lingkungan yang harus dipahami dan diinterpretasikan sama oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Lingkungan diartikan sebagai akumulasi dari kondisi fisik, social, budaya, ekonomi dan politik yang memengaruhi kehidupan dari komunitas tersebut. Sedangkan kesehatan dari suatu komunitas bergantung pada integritas lingkungan fisik, nilai kemanusiaan dalam hubungan social, ketersediaan sumber yang diperlukan dalam mempertahankan hidup dan penanggulangan penyakit, mengatasi gangguan kesehatan secara wajar, pekerjaan dan pendidikan yang dapat tercapai, pelestarian kebudayaan dan toleransi terhadap perbedaan jenis, akses dari garis keturunan serta rasa ingin berkuasa dan memiliki harapan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan lingkungan.

Menurut WHO, setiap tahunnya sekitar 2,2 juta orang di negara-negara berkembang terutama anak-anak meninggal dunia akibat berbagai penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air minum yang aman, sanitasi dan hygiene yang buruk. Selain itu, terdapat bukti bahwa pelayanan sanitasi yang memadai, persediaan air yang aman, sistem pembuangan sampah serta pendidikan hygiene dapat menekan angka kematian akibat diare sampai 65%, serta penyakit-penyakit lainnya sebanyak 26%.

Bersamaan dengan masuknya milenium baru, Departemen Kesehatan

telah mencanangkan Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, yang dilandasi paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.

Berdasarkan paradigma sehat ditetapkan visi Indonesia Sehat, dimana ada 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Untuk perilaku sehat bentuk kongkritnya yaitu perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan. Mengingat dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar (30- 35% terhadap derajat kesehatan), maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah keadaan dimana individu- individu dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat Indonesia telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam rangka :

- Mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain
- Menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
- Memanfaatkan pelayanan Kesehatan
- Mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tujuan Instruksional Umum

Untuk itu marilah kita belajar bersama terkait Konsep PHBS yang dipaparkan dalam Bab ini. Setelah mempelajari BAB ini dengan sungguh sungguh,akhir proses pembelajaran,anda diharapkan dapat:

- Mengetahui dan memahami latar belakang PHBS
- Mengetahui dan memahami pengertian PHBS
- Mengetahui dan memahami Tujuan PHBS
- Mengetahui dan memahami Indikator PHBS

- Mengetahui dan memahami Manfaat PHBS
- Mengetahui dan memahami Sasaran PHBS menurut tatanannya
- Mengetahui dan memahami Faktor yang mempengaruhi PHBS
- Mengetahui dan memahami Pengelolaan PHBS
- Mengetahui dan memahami Peran perawat dalam PHBS

Capaian Pembelajaran

Untuk memudahkan Anda mempelajari bab ini, berikut langkah-langkah belajar yang harus Anda lakukan sebagai berikut.

- Pahami dulu mengenai pentingnya perawat memahami konsep PHBS
- Amati bagaimana kondisi PHBS
- Pelajari setiap topik secara bertahap, dan kerjakan tes dan tugas yang ada di bab ini.
- Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada kesungguhan Anda untuk mempelajari isi bab ini.
- Silakan hubungi fasilitator atau dosen yang mengajar bab ini untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam.
- Kami yakin anda memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk mempelajari bab ini

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian PHBS, Tujuan PHBS, Indikator PHBS, Manfaat PHBS, Sasaran PHBS menurut tatanannya, Faktor yang mempengaruhi PHBS, Pengelolaan PHBS Peran perawat dalam PHBS

A. Definisi PHBS

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatankegiatan kesehatan di masyarakat (Departemen Pekerjaan Umum, 2007: 112).

PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatanAdvokasi, Bina Suasana (Social Support) dan Gerakan Masyarakat (Empowerment) sehingga dapat menerapkan cara-cara

hidup sehat, dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan Kesehatan masyarakat (Depkes RI 2011).

PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari – hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat.

Terdapat langkah – langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar; terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat.

B. Tujuan PHBS

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu - individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Tujuan PHBS adalah mencapai rumah tangga sehat, setiap anggota keluarga menjadi sehat, tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas serta anggota keluarga giat bekerja. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS. Berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.

1. Tujuan Umum

Meningkatnya pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku serta kemandirian perorangan, keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan agar dapat hidup bersih dan sehat.

2. Tujuan Khusus

Meningkatkan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku siswa dan guru di tatanan institusi pendidikan khususnya terhadap program kesehatan lingkungan gaya hidup.

C. Indikator PHBS

Ada beberapa Indikator PHBS antara lain:

1. Menggunakan air bersih

Menggunakan air bersih sangat penting karena air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Air yang bersih tidak mengandung pasir, debu, lumpur, sampah, busa dan kotoran lainnya.

Air tidak berasa, tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau, dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk atau bau belerang. Syarat-syarat air bersih: Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain (dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba), air tidak berwarna harus bening/jernih, dan air tidak keruh.

Manfaat menggunakan air bersih: Terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, thypus, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit atau keracunan. Setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.

2. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk kedalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan.

Manfaat mencuci tangan: Membunuh kuman penyakit yang ada ditangan. Mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera disentri, typhus, cacian, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), flu burung atau severe acute respiratory syndrome (SARS). Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Kapan harus mencuci tangan? Setiap kali tangan kotor, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum dan sesudah menyuapi anak, sebelum memegang makanan, sebelum menyusui bayi.

3. Menggunakan jamban sehat

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penumpungan kotoran dan air untuk membersihkan. Manfaat menggunakan jamban: menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada disekitarnya, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera disentri, typhus, cacian, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan.

4. Memberantas jentik nyamuk

Rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Dengan cara 3 M : menguras, menutup, mengubur.

5. Tidak merokok di dalam rumah

Setiap anggota keluarga tidak boleh merokok di dalam rumah. Bahaya rokok: Menyebabkan kanker rahim dan keguguran, menyebabkan kemandulan dan impotensi, menyebabkan kanker kulit, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, menyebabkan stroke dan jantung, dan gangguan pada mata, seperti katarak. Indikator PHBS di Rumah Tangga

PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

PHBS di Rumah Tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga ber PHBS yang melakukan 10 PHBS yaitu :

a. Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan.

- b. Memberi ASI eksklusif.
- c. Menimbang balita setiap bulan.
- d. Menggunakan air bersih.
- e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
- f. Menggunakan jamban sehat.
- g. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu.
- h. Makan buah dan sayur setiap hari.
- i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari.
- j. Tidak merokok di dalam rumah.

Indicator PHBS di Sekolah

PHBS di Sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat.

Contoh PHBS di kampus:

- a. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan,
- b. Mengonsumsi jajanan sehat,
- c. Menggunakan jamban bersih dan sehat
- d. Olahraga yang teratur
- e. Memberantas jentik nyamuk
- f. Tidak merokok di lingkungan sekolah
- g. Membuang sampah pada tempatnya, dan
- h. Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

D. Manfaat PHBS

Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya :

1. Terhindar dari berbagai penyakit.

Hidup bersih dan sehat akan menjauhkan Anda dari risiko penyakit, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur.

2. Memaksimalkan tumbuh kembang anak.

Dengan menerapkan PHBS, Anda juga turut mendukung pertumbuhan serta perkembangan si kecil agar terhindar dari gangguan seperti stunting. Stunting

adalah kondisi ketika pertumbuhan tubuh anak tidak optimal sehingga panjang atau tinggi badan si kecil tidak sesuai dengan umurnya.

3. Meningkatkan produktivitas.

Tubuh dan pikiran yang sehat juga dapat membantu meningkatkan performa belajar di sekolah dan beraktivitas di lingkungan kerja Anda.

4. Menjaga kebersihan tempat tinggal

Perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadikan rumah Anda sebagai tempat tinggal yang layak huni, nyaman, serta terbebas dari sumber penyakit.

1. Manfaat PHBS di sekolah.

PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat PHBS di Sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat.

2. Manfaat PHBS di Rumah Tangga.

Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain, setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit, rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga dan manfaat PHBS rumah tangga selanjutnya adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi.

PHBS Tatanan Rumah Tangga harus dapat diketahui, dimengerti dan dipraktekkan oleh keluarga, anggota keluarga, serta lingkungan dimana setiap keluarga tinggal. Dalam kondisi ini peran anggota keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah sangat berpengaruh termasuk dalam tersedianya fasilitas serta adanya kebijakan yang mendukung.

3. Manfaat PHBS di Tempat Kerja.

PHBS di Tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif.

4. Manfaat PHBS di Masyarakat

Manfaat PHBS di masyarakat adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat

memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat.

E. Sasaran PHBS menurut tatanannya

Menurut Depkes RI (2007) menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada setiap orang bukanlah hal yang mudah, akan tetapi memerlukan proses yang panjang. Setiap orang hidup dalam tatanannya dan saling mempengaruhi serta berinteraksi antar pribadi dalam tatanan tersebut. Memantau, menilai, dan mengukur tingkat kemajuan tatanan adalah lebih mudah dibandingkan dengan perorangan. Oleh karena itu, pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pendekatan lima tatanan masyarakat, yaitu tatanan rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, tempat kerja, dan institusi kesehatan. Program yang dilaksanakan di kelima tatanan tersebut berlainan, berdasarkan keperluan dan keadaan yang dihadapi. Program-program tersebut antara lain :

1. PHBS pada tatanan rumah tangga.

Salah satu tatanan PHBS yang utama adalah PHBS rumah tangga yang bertujuan memberdayakan anggota sebuah rumah tangga untuk tahu, mau dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat serta memiliki peran yang aktif pada gerakan di tingkat masyarakat. Tujuan utama dari tatanan PHBS di tingkat rumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang sehat. Sasaran PHBS di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga secara keseluruhan dan terbagi dalam :

a. Sasaran primer

Sasaran primer adalah sasaran utama dalam rumah tangga yang akan dirubah perilakunya atau anggota keluarga yang bermasalah (individu dalam keluarga yang bermasalah).

b. Sasaran sekunder

Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu dalam keluarga yang bermasalah misalnya, kepala keluarga, ibu, orang tua, tokoh keluarga, kader tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan lintas sektor terkait, PKK.

c. Sasaran tersier

Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS misalnya, kepala desa, lurah, camat, kepala Puskesmas, guru, tokoh masyarakat.

2. PHBS tatanan institusi Pendidikan.

Di insituti pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan dan lain- lain), sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan Insituti Pendidikan Ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarng tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain. Sasaran PHBS di tatanan institusi pendidikan adalah seluruh anggota keluarga institusi pendidikan dan terbagi dalam :

a. Sasaran primer

Sasaran primer adalah sasaran utama dalam institusi pendidikan yang akan dirubah perilakunya atau siswa dan guru yang bermasalah (individu/kelompok dalam institusi pendidikan yang bermasalah).

b. Sasaran sekunder

Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu dalam institusi pendidikan yang bermasalah misalnya, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, kader kesehatan sekolah, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan lintas sektor terkait, PKK.

c. Sasaran tersier

Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi Pendidikan misalnya, kepala desa, lurah, camat, kepala Puskesmas, Diknas, guru, tokoh masyarakat dan orang tua siswa.

3. PHBS tatanan tempat umum.

PHBS di tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat. Sasaran PHBS di tatanan tempat umum terbagi dalam :

a. Sasaran primer

Sasaran primer adalah sasaran utama di tempat umum yang akan dirubah perilakunya yaitu pengurus maupun pengunjung yang bermasalah dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

b. Sasaran sekunder

Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu/ kelompok di tempat umum yang bermasalah yaitu perilaku masyarakat di sekitar tempat umum.

c. Sasaran tersier

Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di tempat umum misalnya, kepala desa, lurah, camat, kepala Puskesmas, Dinas kebersihan, guru, tokoh masyarakat.

4. PHBS tatanan tempat kerja.

PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik dan pengelola usaha/ kantor, agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Sasaran tatanan di tempat kerja yaitu:

a. Sasaran primer

Sasaran primer adalah sasaran utama dalam lingkungan tempat kerja yang akan dirubah perilakunya yaitu seluruh aspek yang ada dalam suatu perusahaan (karyawan dan pemilik perusahaan) yang bermasalah.

b. Sasaran sekunder

Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu yang bermasalah dalam lingkungan tempat kerja yaitu pemilik perusahaan, mitra kerja.

c. Sasaran tersier

Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan Kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS dalam lingkungan perusahaan, yaitu kepala desa, lurah, camat, kepala Puskesmas, tokoh masyarakat.

5. PHBS tatanan pelayanan Kesehatan.

PHBS di institusi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Institusi Kesehatan. Sasaran tatanan pelayanan Kesehatan yaitu :

a. Sasaran primer

Sasaran primer adalah sasaran utama dalam institusi kesehatan yang akan dirubah perilakunya atau bermasalah (individu/kelompok) yaitu pengunjung, pengguna fasilitas, dan paramedis dalam institusi kesehatan.

b. Sasaran sekunder

Sasaran sekunder adalah sasaran yang dapat mempengaruhi individu dalam institusi kesehatan yang bermasalah misalnya, kepala ruangan, dokter, dan kepala rumah sakit.

c. Sasaran tersier

Sasaran tersier adalah sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan, kebijakan, dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di institusi kesehatan misalnya Dinas Kesehatan.

F. Faktor yang mempengaruhi PHBS

Menurut Lawrence Green, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat dibagi menjadi 3 bagian yaitu faktor predisposisi (Umur, Tingkat Pengetahuan masyarakat dan tingkat Pendidikan masyarakat), faktor pemungkin (fasilitas dan sarana) dan Faktor penguat (Dukungan Tokoh masyarakat, perilaku petugas kesehatan, dan tersamapaikan atau tidaknya promosi kesehatan PHBS terhadap masyarakat tersebut) (Green, 2005).

Sedangkan menurut Notoadmojo, Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat ternyata sangat berpengaruh dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Hal ini sudah dibuktikan melalui penelitian oleh Desi. Selain itu, pada penelitian Desi juga dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. (Notoadmojo, 2007).

Ada pula faktor yang mempengaruhi PHBS, antara lain:

1. Sosial ekonomi berdasarkan umur.
2. Sosial ekonomi berdasarkan Pendidikan.
3. Sosial ekonomi berdasarkan pekerjaan.
4. Sosial ekonomi berdasarkan penghasilan keluarga.
5. Tingkat pengetahuan tentang PHBS.
6. Akses pelayanan Kesehatan.
7. Motivasi untuk hidup bersih dan sehat.

Faktor yang lain lingkungan dan perilaku

1. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari diri seseorang. Lingkungan dibedakan atas:

Lingkungan Fisik Biotik dan Abiotik air, udara, tanah, tumbuhan, manusia, hewan, dll) Sosial ekonomi dan budaya hubungan antar manusia, keluarga dan masyarakat

2. Perilaku

Perilaku merupakan suatu respon dari seseorang/organisme terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima.

G. Pengelolaan PHBS

Untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tiap tatanan; diperlukan pengelolaan manajemen program PHBS melalui tahap pengkajian, perencanaan, penggerakan pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan penilaian. Selanjutnya kembali lagi ke proses semula. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bagan berikut ini :

1. Pengkajian

Tujuan pengkajian adalah untuk mempelajari, menganalisis dan merumuskan masalah perilaku yang berkaitan dengan PHBS. Kegiatan pengkajian meliputi pengkajian PHBS secara kuantitatif, pengkajian PHBS secara kualitatif dan pengkajian sumber daya (dana, sarana dan tenaga).

a. Pengkajian-pengkajian masalah PHBS secara kuantitatif.

Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Kegiatan ini meliputi data perilaku dan bukan perilaku yang berkaitan dengan program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan lingkungan, gaya hidup, dan JPKM dan data lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Data tersebut dapat diperoleh dari Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sebagai informasi pendukung untuk memperkuat permasalahan PHBS yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya dibuat simpulan hasil analisis data sekunder tersebut.

Hasil yang diharapkan pada tahap pengkajian ini:

- 1) Teridentifikasinya masalah perilaku kesehatan di wilayah tertentu
- 2) Dikembangkannya pemetaan PHBS per tatanan
- 3) Teridentifikasinya masalah lain yang berkaitan (masalah kesehatan, faktor penyebab perilaku, masalah pelaksanaan dan sumber daya penyuluhan, masalah kebijakan, administrasi, organisasi, dan lain-lain)

b. Cara Pengambilan Sampel PHBS Tatanan Rumah Tangga

Dalam melaksanakan pengumpulan data perilaku sehat di tatanan rumah tangga secara keseluruhan terlalu berat untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, waktu dan sumber daya yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Metode Pengambilan sampel perilaku sehat di tatanan rumah tangga adalah dengan rapid survai atau survai cepat. Sedangkan untuk tatanan lainnya dapat dilakukan keseluruhan populasi. Berikut ini cara pengambilan sampel tatanan rumah tangga di tingkat kabupaten / kota. Untuk mengukur masalah PHBS di

tatanan rumah tangga, maka jumlah sampel harus mencukupi. Perhitungan sampel sederhana direkomendasi WHO yaitu : $30 \times 7 = 210$ rumah tangga (30 kluster dan 7 rumah tangga per cluster). Di tingkat kabupaten/ kota dapat disertakan dengan kelurahan / desa.

Ada 2 tahapan cluster yang digunakan untuk tatanan rumah tangga, tahap pertama dapat dipilih sejumlah kluster (kelurahan/desa), tahap kedua ditentukan rumah tangganya.

Langkah-langkah cara pengambilan sampel tatanan rumah tangga :

- 1) Langkah 1: List kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten.
- 2) Langkah 2: Tulis jumlah desa yang berada pada masing masing kecamatan.
- 3) Langkah 3: Beri nomor urut desa mulai no 1 sampai terakhir.
- 4) Langkah 4: Hitung interval desa dengan cara total desa/ 30.
- 5) Langkah 5: Tentukan nomor Kluster pertama desa. Dengan mengundi nomor unit desa. Selanjutnya desa kedua dapat ditentukan dengan menambahkan interval. Demikian seterusnya hingga diperoleh 30 kluster.
- 6) Langkah 6: Dan desa yang terpilih diambil secara acak 7 rumah tangga.

c. Pengkajian PHBS secara kualitatif

Setelah ditentukan prioritas masalah perilaku, selanjutnya dilakukan pengkajian kualitatif Tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kebiasaan, kepercayaan, sikap, norma, budaya perilaku masyarakat yang tidak terungkap dalam kajian kuantitatif PHBS.

Ada dua metode untuk melakukan pengkajian PHBS secara kualitatif, yaitu:

- 1) Diskusi Kelompok Terarah (DKT).
- 2) Wawancara Perorangan Mendalam (WPM).

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1) Diskusi Kelompok Terarah (DKT).

Adalah diskusi informal bersama 6 s/d 10 orang, tujuannya untuk mengungkapkan informasi yang lebih mendalam tentang masalah perilaku PHBS.

Dalam DKT:

- a) Diperlukan seorang pemandu yang terampil mendorong orang untuk saling bicara dan memperoleh pemahaman tentang perasaan dan pikiran peserta yang hadir terhadap masalah tertentu.
 - b) Melibatkan dan memberikan kebebasan peserta untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya.
 - c) Memperoleh informasi tentang nilai-nilai kepercayaan dan perilaku seseorang yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara biasa.
- 2) Wawancara Perorangan Mendalam (WPM).

Adalah wawancara antara pewawancara yang terampil dengan perorangan selaku sumber informasi kunci, melalui serangkaian Tanya jawab (dialog) yang bersifat terbuka dan mendalam.

Dalam WPM:

- a) Pewawancara adalah seorang yang terampil dalam menggali informasi secara mendalam tentang perasaan dan pikiran tentang masalah tertentu.
 - b) Sumber informasi kunci adalah peserta wawancara yang dianggap mampu dan dipandang menguasai informasi tentang masalah tertentu.
 - c) Tanya jawab dilakukan secara terbuka dan mendalam.
- 3) Pengkajian sumber daya (dana, tenaga, dan sarana).

Pengkajian sumber daya dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program PHBS, bentuk kegiatannya:

- a) Kajian tenaga pelaksana PHBS, secara kuantitas (jumlah) dan pelatihan yang pernah diikuti oleh lintas program maupun lintas sektor.
- b) Penjajagan dana yang tersedia di lintas program dan lintas sektoral dalam jumlah dan sumbernya.
- c) Penjajagan jenis media dan sarana yang dibutuhkan dalam jumlah dan sumbernya.

2. Perencanaan

Penyusunan rencana kegiatan PHBS gunanya untuk menentukan tujuan dan strategi komunikasi PHBS. Adapun langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan Berdasarkan kegiatan pengkajian PHBS dapat ditentukan klasifikasi PHBS wilayah maupun klasifikasi PHBS tatanan, maka dapat ditentukan masalah perilaku kesehatan masyarakat di tiap tatanan dan wilayah. Selanjutnya, berdasarkan masalah perilaku kesehatan dan hasil pengkajian sumber daya petugas kesehatan, maka ditentukan tujuan yang akan dicapai untuk mengatasi masalah PHBS yang ditemukan. Contoh hasil pengkajian PHBS secara kuantitatif ditemukan masalah merokok pada tatanan rumah tangga, maka ditentukan tujuannya. Tujuan Umum : Menurunkan prosentase keluarga yang merokok selama satu tahun. Tujuan Khusus : Menurunkan prosentase tatanan rumah tangga yang merokok, dari 40% menjadi 20%.
- b. Menentukan jenis kegiatan intervensi Setelah ditentukan tujuan, selanjutnya ditentukan jenis kegiatan Intervensi yang akan dilakukan. Caranya adalah dengan mengembangkan berbagai alternatif intervensi, kemudian dipilih intervensi mana yang bisa dilakukan dengan dikaitkan pada ketersediaan sumber daya.

Penentuan kegiatan intervensi terpilih didasarkan pada :

- 1) Prioritas masalah PHBS, yaitu dengan memilih topic penyuluhan yang sesuai dengan urutan masalah PHBS.
- 2) Wilayah garapan, yaitu mengutamakan wilayah yang mempunyai PHBS hasil kajian rendah.
- 3) Penentuan tatanan yang akan diintervensi , yaitu menentukan tatanan yang akan digarap, baik secara menyeluruh atau sebatas pada tatanan tertentu. Kemudian secara bertahap dikembangkan ke tatanan lain.
- 4) Penentuan satu jenis sasaran untuk tiap tatanan, yaitu mengembangkan PHBS pada tiap tatanan, tetapi hanya satu jenis sasaran untuk tiap tatanan. Misalnya, satu unit tatanan sekolah, satu unit pasar untuk tatanan tempat umum, satu unit industri rumah tangga untuk tatanan tempat kerja.

Rumusan rencana kegiatan intervensi terpilih pada intinya merupakan operasional strategi PHBS, yaitu:

- 1) Advokasi. kegiatan pendekatan pada para tokoh / pimpinan wilayah.
- 2) Bina Suasana. kegiatan mempersiapkan kerjasama lintas program, lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, LSM, dunia usaha, swasta dan lain lain.
- 3) Gerakan masyarakat. kegiatan mempersiapkan dan menggerakkan sumber daya, mulai mempersiapkan petugas, pengadaan media dan sarana.

3. **Penggerakan**

Tahap penggerakan dan melaksanakan PHBS sebagai berikut :

a. Advokasi (pendekatan pada para pengambil keputusan)

- 1) Ditingkat keluarga/rumah tangga, strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga / bapak/suami,ibu, kakek, nenek. Tujuannya agar para pengambil keputusan di tingkat keluarga/rumah tangga dapat meneladani dalam berperilaku sehat. Memberikan dukungan kemudahan, pengayoman dan bimbingan kepada anggota keluarga dan lingkungan disekitarnya.
- 2) Ditingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada para pimpinan atau pengambil keputusan, seperti Kepala Puskesmas, pejabat di tingkat kabupaten/kota, yang secara fungsional maupun struktural Pembina program kesehatan di wilayahnya. Tujuannya adalah agar para pimpinan atau pengambil keputusan mengupayakan kebijakan, program atau peraturan yang berorientasi sehat, seperti adanya peraturan tertulis, dukungan dana, komitmen, termasuk memberikan keteladanan.

Langkah-langkah Advokasi

- 1) Tentukan sasaran yang akan diadvokasi, baik sasaran primer, sekunder atau tersier
- 2) Siapkan informasi data kesehatan yang menyangkut PHBS di 5 tatanan.

- 3) Tentukan kesepakatan dimana dan kapan dilakukan advokasi.
- 4) Lakukan advokasi dengan cara yang menarik dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat.
- 5) Simpulkan dan sepakati hasil advokasi.
- 6) Buat ringkasan eksekutif dan sebarluaskan kepada sasaran.

b. Mengembangkan dukungan suasana

- 1) Di tingkat keluarga/RT, strategi ini ditujukan kepada para kepala keluarga/suami/bapak ibu. kakek. nenek. dan lain-lain. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS di lingkungan keluarga. Caranya antara lain melalui anjuran untuk selalu datang ke Posyandu mengingatkan anggota keluarga untuk tidak merokok di dekat ibu hamil dan balita.
- 2) Di tingkat petugas, strategi ini ditujukan kepada kelompok sasaran sekunder, seperti petugas kesehatan, kader, lintas sektor, lintas program, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan, dan media masa. Tujuannya adalah agar kelompok ini dapat mengembangkan atau menciptakan suasana yang mendukung dilaksanakannya PHBS. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, lokakarya, seminar studi banding, pelatihan, dan sebagainya.

Langkah-langkah Pengembangan Dukungan Suasana :

- 1) Menganalisis dan mendesain metode dan teknik kegiatan dukungan suasana, seperti : demonstrasi, pelatihan, sosialisasi, orientasi.
- 2) Mengupayakan dukungan pimpinan, program, sektor terkait pada tiap tatanan dalam bentuk adanya komitmen dan dukungan sumber daya.
- 3) Mengembangkan metoda, teknik dan media yang telah diuji coba.
- 4) Disempurnakan
- 5) Membuat format penilaian dan menilai hasil kegiatan.

c. Gerakan masyarakat

- 1) Di tingkat keluarga/RT, strategi ini ditujukan kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk lingkungannya dengan cara menjadi kader posyandu, aktif di LSM peduli kesehatan dll. Tujuannya agar kelompok sasaran meningkat pengetahuan, kesadaran maupun kemampuannya, sehingga dapat berperilaku sehat. Caranya dengan penyuluhan perorangan, kelompok, membuat gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Ditingkat petugas strategi ini ditujukan kepada sasaran primer Meliputi pimpinan puskesmas. kepala dinas kesehatan, pemuka masyarakat. Tujuannya meningkatkan motivasi petugas untuk membantu masyarakat

dalam menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Caranya antara lain melalui penyuluhan kelompok, lokakarya, seminar, studi banding, pelatihan, dan lain-lain.

d. Langkah-langkah kegiatan gerakan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan.
- 2) Menganalisis dan mendesain metode dan teknik kegiatan pemberdaya seperti pelatihan, pengembangan media komunikasi untuk penyuluh individu, kelompok dan massa, lomba, sarasehan dan lokakarya.
- 3) Mengupayakan dukungan pimpinan, program, sektor terkait pada tatanan dalam bentuk komitmen dan sumber daya.
- 4) Mengembangkan metoda, teknik dan media yang telah diujicoba disempurnakan.
- 5) Membuat format penilaian dan menilai hasil kegiatan bersamasama dengan lintas program dan lintas sektor pada tatanan terkait.
- 6) Menyusun laporan serta menyajikannya dalam bentuk tertulis (ringkasan, eksekutif).

4. Pemantauan dan Penilaian

a. Pemantauan

Untuk mengetahui program PHBS telah berjalan dan memberikan hasil atau dampak seperti yang diharapkan, maka perlu dilakukan pemantauan. Waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala atau pada pertemuan bulanan, topik bahasannya adalah kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dikaitkan dengan jadwal kegiatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kendala-kendala yang muncul perlu dibahas dan dicari solusinya. Cara pemantauan dapat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan lapangan ke tiap tatanan atau dengan melihat buku kegiatan/laporan kegiatan intervensi.

b. Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian dilaksanakan oleh pengelola PHBS lintas program dan lintas sektor. Penilaian PHBS meliputi masukan, proses dan luaran kegiatan. Misalnya jumlah tenaga terlatih PHBS, media yang telah dikembangkan, frekuensi dan cakupan penyuluhan. Waktu penilaian dapat dilakukan pada setiap tahun atau setiap dua tahun. Caranya dengan membandingkan data dasar PHBS dibandingkan dengan data PHBS hasil evaluasi selanjutnya menilai kecenderungan masing-masing indikator apakah mengalami peningkatan atau penurunan, mengkaji penyebab masalah dan melakukan pemecahannya, kemudian merencanakan intervensi

berdasarkan data hasil evaluasi PHBS. Contoh di Kabupaten Pariaman data perilaku tidak merokok tahun 2001 menunjukkan 44,2% sedangkan tahun 2002 ada peningkatan sebesar 73,6 %.

- c. Cara melakukan penilaian melalui :
 - 1) Pengkajian ulang tentang PHBS.
 - 2) Menganalisis data PHBS oleh kader/koordinator PHBS
 - 3) Melakukan analisis laporan rutin
 - 4) Observasi. Wawancara mendalam. diskusi kelompok terarah kepada petugas, kader dan keluarga.
- d. Hasil yang dicapai pada tahap pemantauan dan penilaian adalah :
 - 1) Pelaksanaan program PHBS sesuai rencana.
 - 2) Adanya pembinaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
 - 3) Adanya upaya jalan keluar apabila terjadi kemacetan/ hambatan.
 - 4) Adanya peningkatan program PHBS.

H. Peran Perawat dalam PHBS

1. Sebagai Pendidik

Peran perawat sebagai pendidik yaitu peran perawat yang memberikan informasi masyarakat untuk memberikan informasi yang berupa pengajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan dasar PHBS yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai sasaran pemberian keperawatan yang efektif biaya, aman dan berkualitas tinggi sedangkan perawat sebagai pendidik di institusi pendidikan keperawatan untuk membentuk perawat-perawat baru yang berkualitas.

Mengkaji kebutuhan klien untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Dari hasil pengkajian diharapkan dapat diketahui tingkat pengetahuan klien, informasi apa yang diperlukan klien, dan apa yang ingin diketahui klien. Meningkatkan dan memelihara kesehatan klien melalui penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Melaksanakan penyuluhan atau pendidikan kesehatan untuk pemulihan kesehatan klien antara lain tentang pengobatan, hygiene, perawatan serta gejala dan tanda bahaya. Menyusun program penyuluhan atau pendidikan kesehatan baik untuk topic sehat ataupun sakit seperti nutrisi, latihan, penyakit, dan pengelola penyakit. Mengajarkan pada klien informasi tentang tahapan perkembangan. Membantu klien untuk memilih sumber informasi kesehatan dari buku-buku, Koran TV, teman dan lainnya.

2. Sebagai advokat

Peran perawat sebagai advokat yaitu tindakan perawat dalam mencapai suatu tujuan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat atau bertindak untuk

mencegah kesalahan yang tidak diinginkan ketika pasien sedang menjalankan pengobatan. Sebagai advokat perawat juga berperan penting dalam memberi pendapat dan kemudian mendukung keputusan yang diambil pasien.

Peran perawat advokat ini dapat kita temukan saat perawat memberikan informasi tambahan mengenai terapi medis kepada pasien, efek samping, manfaat dan tujuannya namun pasien bingung dan berusaha memutuskan tindakan yang terbaik bagi kesehatannya, untuk itu perawat dibutuhkan memberikan informasi lengkap bagi pasien dan berusaha menolak bila tindakan itu membahayakan kondisi pasien dan melanggar hak-hak pasien. Bila dihubungkan dengan teori kerangka kerja dari Milio (1976) tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, dan teori sosial kritis, hal ini mengharuskan perawat untuk menganalisis tindakan yang tepat dan berpikir kritis bagi kesehatan pasien.

3. **Sebagai peneliti**

Perawat sebagai peneliti yaitu peran perawat yang menerjemahkan temuan riset, bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, mengidentifikasi, menganalisis data, memecahkan masalah klinis dengan menerapkan prinsip dan metode penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan praktik keperawatan dan meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan keperawatan

4. **Sebagai konsultan**

Perawat sebagai konsultan yaitu peran perawat yang bertugas sebagai tempat konsultasi pasien dalam pemberian informasi, dukungan atau memberi ajaran tentang tujuan pelayanan. keperawatan yang diberikan. Konsultasi ini dilakukan oleh beberapa profesional kesehatan yang secara bersama-sama membuat keputusan dengan hati-hati dengan memberikan saran-saran secara langsung kepada pasien.

Perawat ini mempunyai fungsi yaitu:

- a. fungsi klinis sebagai pemberi nasehat dalam lingkungan praktek klinis dan membantu mengembangkan keahlian dalam lingkungan praktek.
- b. fungsi strategis sebagai bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan mempromosikan pengembangan standar-standar praktek terbaik dalam kerangka klinis pemerintahan.

5. **Perawat Sebagai Pemberi Perawatan**

Perawat sebagai pemberi perawatan secara langsung yaitu peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada individu, keluarga dan kelompok dengan menggunakan energi dan waktu seminimal mungkin Perawat ini langsung mengkaji kondisi kesehatan pasien, merencanakan,

mengimplementasi dan mengevaluasi asuhan keperawatan. Perawat secara langsung terlibat dalam proses penyembuhan pasien tidak hanya secara fisik saja tapi holistik yaitu penyembuhan kesehatan emosi, spiritual, dan sosial. (Keeling dan Ramos, 1995).

6. **Perawat Sebagai Pemasaran kesehatan.**

Perawat sebagai pemasaran kesehatan pada masyarakat atau social marketer yaitu peran perawat dalam mempromosikan kesehatan atau gaya hidup sehat, PHBS. Kegiatan promosi ini bersifat sosial dan dibuat berdasarkan kesukarela.

I. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan PHBS?
 - A. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Benar)
 - B. Pendidikan Hidup Bersih dan Sehat
 - C. Program Hidup Bersih dan Sehat
 - D. Pengobatan Hidup Bersih dan Sehat
 - E. Pengelolaan Hidup Bersih dan Sehat
2. Salah satu tujuan utama dari PHBS adalah:
 - A. Meningkatkan pengetahuan tentang obat-obatan
 - B. Menciptakan masyarakat yang sadar kesehatan (Benar)
 - C. Meningkatkan jumlah rumah sakit
 - D. Mengurangi penggunaan air bersih
 - E. Meningkatkan penghasilan masyarakat
3. Yang tidak termasuk Indikator PHBS di rumah tangga adalah:
 - A. Menggunakan air bersih
 - B. Mencuci tangan dengan sabun
 - C. Mengonsumsi makanan cepat saji (Benar)
 - D. Menggunakan jamban sehat
 - E. Memberantas jentik nyamuk
4. Apa manfaat utama dari menerapkan PHBS?
 - A. Menambah beban biaya kesehatan
 - B. Meningkatkan risiko terkena penyakit
 - C. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat (Benar)
 - D. Mengurangi produktivitas kerja
 - E. Mempercepat penyebaran penyakit

5. Sasaran PHBS di tatanan rumah tangga meliputi:
- A. Hanya kepala keluarga
 - B. Semua anggota keluarga (Benar)
 - C. Hanya anak-anak
 - D. Hanya perempuan
 - E. Hanya orang dewasa

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. C
- 5. B

Latihan easi

- 1. Apa dampak jika kita kurang menerapkan PHBS di rumah tangga?
- 2. Bagaimana solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS?
- 3. Apa manfaat PHBS bagi masyarakat?
- 4. Apa manfaat PHBS bagi lingkungan?
- 5. Apa saja contoh perilaku PHBS di sekolah?

J. Rangkuman Materi

PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Tujuan PHBS adalah mencapai rumah tangga sehat, setiap anggota keluarga menjadi sehat, tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas serta anggota keluarga giat bekerja. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melaksanakan PHBS. Berperan aktif dalam gerakan PHBS di masyarakat.

K. Glosarium

PHBS : Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

M : menguras, menutup, mengubur

WHO : world Health Organization

L. Daftar Pustaka

- Depkes RI. (2011). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jakarta: Departemen Kesehatan Indonesia.
- Depkes RI.(2009). Rumah Tangga Sehat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.Jakarta: Depkes RI.
- Effendi,L,d.(2004).PHBS Pada SD Negeri Cikeusal Kidul 01 Ketinggungsan Jawa Tengah Tahun 2004. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan.
- Fauzianor, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga. Skripsi, 1-33.
- Imbar, A. G. (2018). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal KESMAS. Jakarta:Rineka Cipta.
- Kurnia, A. (2013). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2013.
- Maryuani, A. (2012). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jakarta: SalembaMedika.
- Mengajar dalam Pendidikan.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Mubarak,W.(2007).Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo,S.(2014).Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.Jakarta:
- Nurhajanti, N. (2011). Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. 1-18.
- Permenkes No 2269 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. (n.d.). Rineka Cipta.
- Santoso Soegeng dkk. (1999) Kesehatan dan Gizi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemirat (2004). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Sumantri, Arif. 2010. Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Sumijatun, et al.(2005). Konsep Dasar Keperawatan Komunitas. Jakarta : EGC
- Taryatman. (2016). "Budaya Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Dasar", Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 3. No. 1. September.
- Undang Undang No36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.(n.d.).
- Wawan,A.(2010).Teori dan Pengukuran,Pengetahuan,Sikap dan Perilaku.

PROFIL PENULIS



Nur Fadhilah, M.Kes., Ph.D., lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M.Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa University Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000

sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Promosi Kesehatan dan Metodologi

Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, dan penulis konsen dalam program pencegahan dan pengendalian TBC berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Bandar Lampung, dan diberikan amanah sebagai Koordinator Indonesia Ramah Lansia (IRL) Kota Bandar Lampung, sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung. Berbagai penghargaan sebagai dosen terbaik tingkat propinsi dan Nasional pernah diraih, dan tahun 2024 terpilih sebagai sosok inspiratif tingkat Propinsi.



Ns. Umi Aniroh, S.Kep., M.Kes., Lahir di Semarang, 14 Agustus 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai staf pengajar di Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo. Saat ini penulis bekerja di Universitas Ngudi Waluyo mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat seminar, maupun menulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: umianiroh3@gmail.com

PROFIL PENULIS



Syahrul, SKM., M.Kes., Lahir di Pariaman, 03 Oktober 1962. Pendidikan setelah tamat SMA N Solok, mengikuti pendidikan Sekolah Pembantu Paramedis Umum tahun 1981 tamat tahun 1982 kemudian melanjutkan sebagai tugas belajar Lulus Akper Depkes Otten Bandung tamat tahun 1988, S1 Kesehatan Masyarakat FKM USU Medan tamat Tahun 1993, dan S2 Kesehatan Masyarakat FKM UI Jakarta tamat Tahun 2004. Mengawali karier sebagai PNS di Puskesmas Kampung Dalam pada tahun 1982, selanjutnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Pada Tahun 2004 pindah ke Dinas Kesehatan Kota Pariaman sampai mengakhiri pengabdian sebagai ASN dengan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun, karena ketertarikan kepada dunia pendidikan diawali sebagai Guru Tidak Tetap di Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Kabupaten Pariaman, Dosen dan Ketua Pada Stikes Nantongga Lubuk Alung dan sekarang setelah Purna Bakti pada tahun 2022 mengabdikan waktu sebagai Ketua Stikes Piala Sakti Pariaman. Penulis juga sebagai pengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keselamatan Pasien dan K3 serta Pendidikan dan Promosi Kesehatan.. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Selain itu sebagai insan perawat mengembangkan organisasi PPNI di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman selaku ketua DPD dan terakhir saat ini sebagai Dewan Pertimbangan DPW PPNI Propinsi Sumatera Barat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syahrul.mkes@gmail.com
Motto: "Living your life well"



Dewi Yuliana, S.Kep., Ns., M.Kep., Dosen Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan, Universitas Mitra Indonesia Penulis lahir di Kotabumi tanggal 1 April 1988. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Mitra Indonesia sejak tahun 2012. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Keperawatan (S1 Keperawatan) di STIKES Mitra Lampung tahun 2006. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners di STIKES Mitra Lampung. Kemudian penulis menyelesaikan program pendidikan Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Maternitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2017. Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif diberbagai organisasi keperawatan dan kegiatan ilmiah keperawatan serta kesehatan. Penulis juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kesehatan di Universitas Mitra Indonesia sejak tahun 2012. Penulis telah menulis berbagai artikel di berbagai jurnal nasional baik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menulis karya ilmiah dalam bentuk buku referensi.

PROFIL PENULIS



Heri Triwibowo, SKM., SKep.Ns., M.Kes., Lahir di Magetan, 24 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga tahun 2000 dan S1 Keperawatan UNIPDU Jombang tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 UNS dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 AKPER Bina Sehat PPNI, STIKes Bina Sehat sampai berubah jadi Universitas Bina Sehat

PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Promkes, Keluarga, Gerontik, Antropologi, Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heriubsppni@gmail.com

Buku "Promosi Kesehatan: Strategi, Konsep, dan Aplikasi dalam Keperawatan" dirancang khusus untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam bidang promosi kesehatan. Buku ini menjelaskan secara rinci lima strategi pendekatan promosi kesehatan yang mencakup edukasi, advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan lintas sektor, dan kebijakan publik. Strategi-strategi tersebut disajikan secara komprehensif dan aplikatif, memudahkan penerapan dalam berbagai konteks klinis dan komunitas.

Konsep dasar promosi kesehatan dibahas secara mendalam untuk memberikan landasan teori yang kokoh bagi para pembaca. Selain itu, buku ini juga menghadirkan panduan praktis mengenai perencanaan promosi kesehatan yang sistematis dan efektif, memastikan setiap upaya promosi kesehatan dilaksanakan dengan efisiensi tinggi di lapangan.

Lebih lanjut, buku ini menampilkan aplikasi nyata promosi kesehatan dalam praktik keperawatan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun kelompok. Contoh-contoh kasus yang disajikan membantu pembaca menghubungkan teori dengan realitas praktik di lapangan.

Selain itu, buku ini memberikan perhatian khusus pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), suatu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang interaktif dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi pedoman penting dalam pembentukan perilaku sehat yang berkelanjutan di komunitas.

Dengan muatan yang lengkap dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu mendukung mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menjalankan peran mereka secara lebih efektif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Buku "Promosi Kesehatan: Strategi, Konsep, dan Aplikasi dalam Keperawatan" dirancang khusus untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam bidang promosi kesehatan. Buku ini menjelaskan secara rinci lima strategi pendekatan promosi kesehatan yang mencakup edukasi, advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan lintas sektor, dan kebijakan publik. Strategi-strategi tersebut disajikan secara komprehensif dan aplikatif, memudahkan penerapan dalam berbagai konteks klinis dan komunitas.

Konsep dasar promosi kesehatan dibahas secara mendalam untuk memberikan landasan teori yang kokoh bagi para pembaca. Selain itu, buku ini juga menghadirkan panduan praktis mengenai perencanaan promosi kesehatan yang sistematis dan efektif, memastikan setiap upaya promosi kesehatan dilaksanakan dengan efisiensi tinggi di lapangan.

Lebih lanjut, buku ini menampilkan aplikasi nyata promosi kesehatan dalam praktik keperawatan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun kelompok. Contoh-contoh kasus yang disajikan membantu pembaca menghubungkan teori dengan realitas praktik di lapangan.

Selain itu, buku ini memberikan perhatian khusus pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), suatu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang interaktif dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi pedoman penting dalam pembentukan perilaku sehat yang berkelanjutan di komunitas.

Dengan muatan yang lengkap dan aplikatif, buku ini diharapkan mampu mendukung mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menjalankan peran mereka secara lebih efektif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-29-6



9

786347

294296